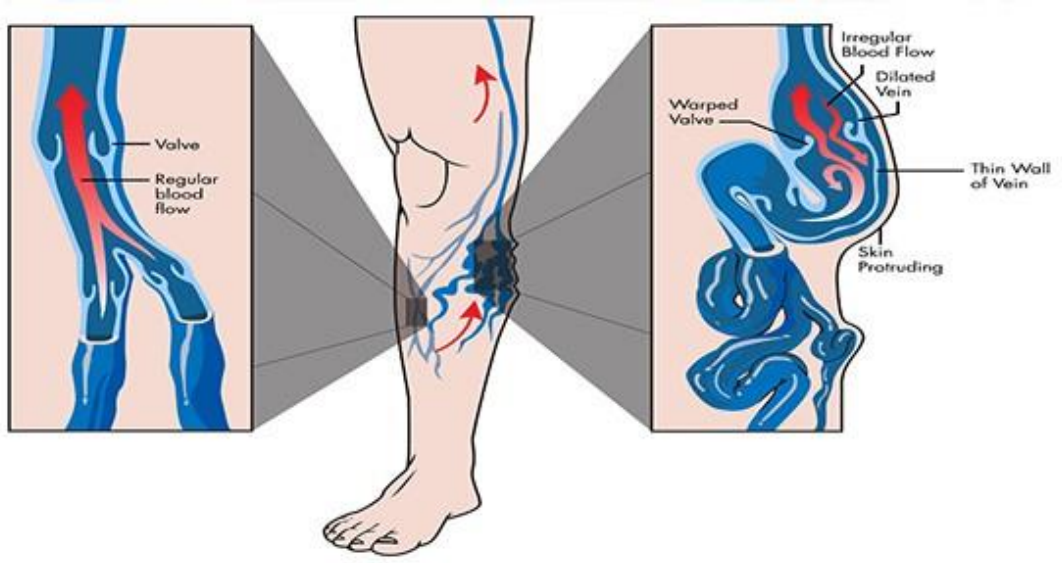
Université de Bejaia
Faculté de Médecine
Sémiologie Médicale UE1

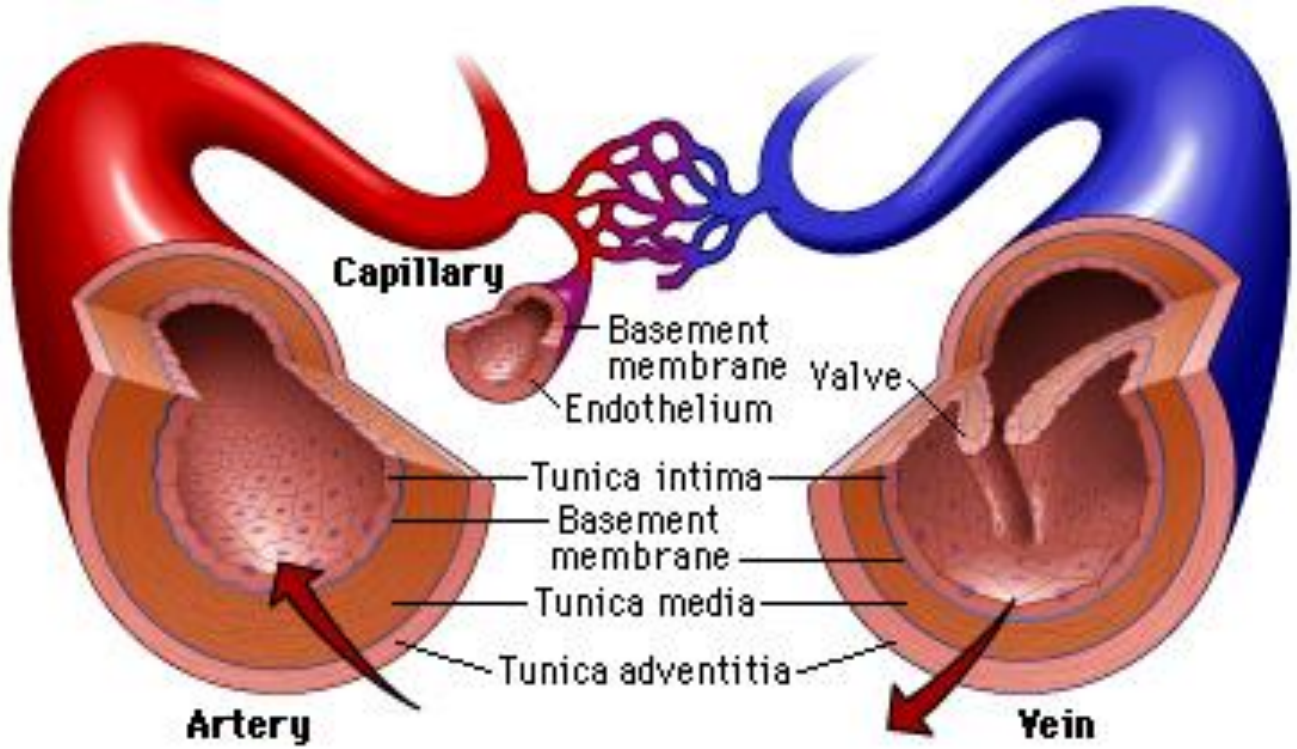
جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

faculté de médecine de béjaia

Sémiologie Veineuse

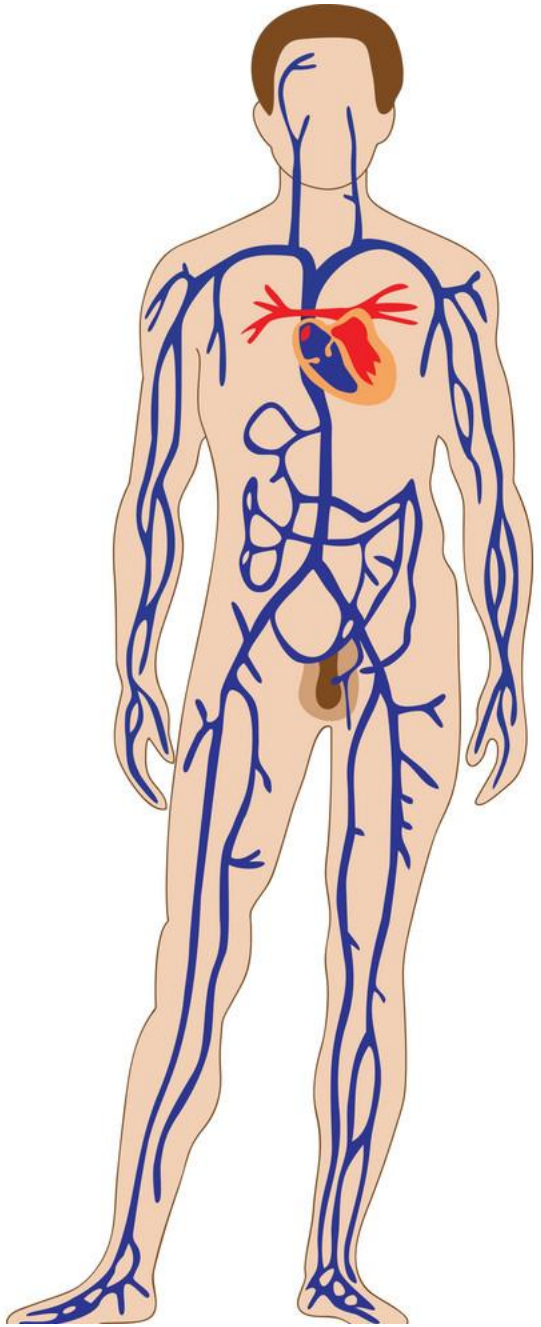


Dr Terra. Service de médecine interne du CHU Bejaia

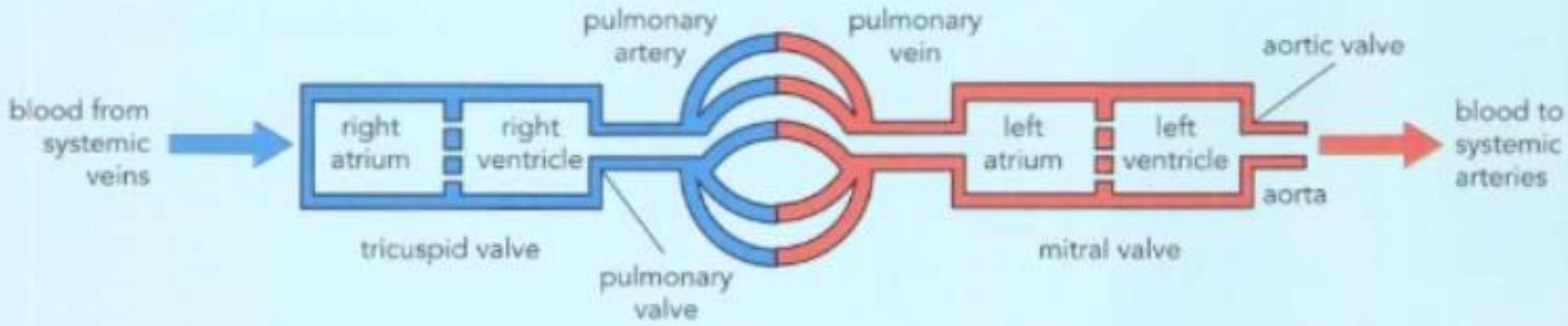

Capillary
Basement membrane
Endothelium
Valve
Tunica intima
Basement membrane
Tunica media
Tunica adventitia
Artery
Vein

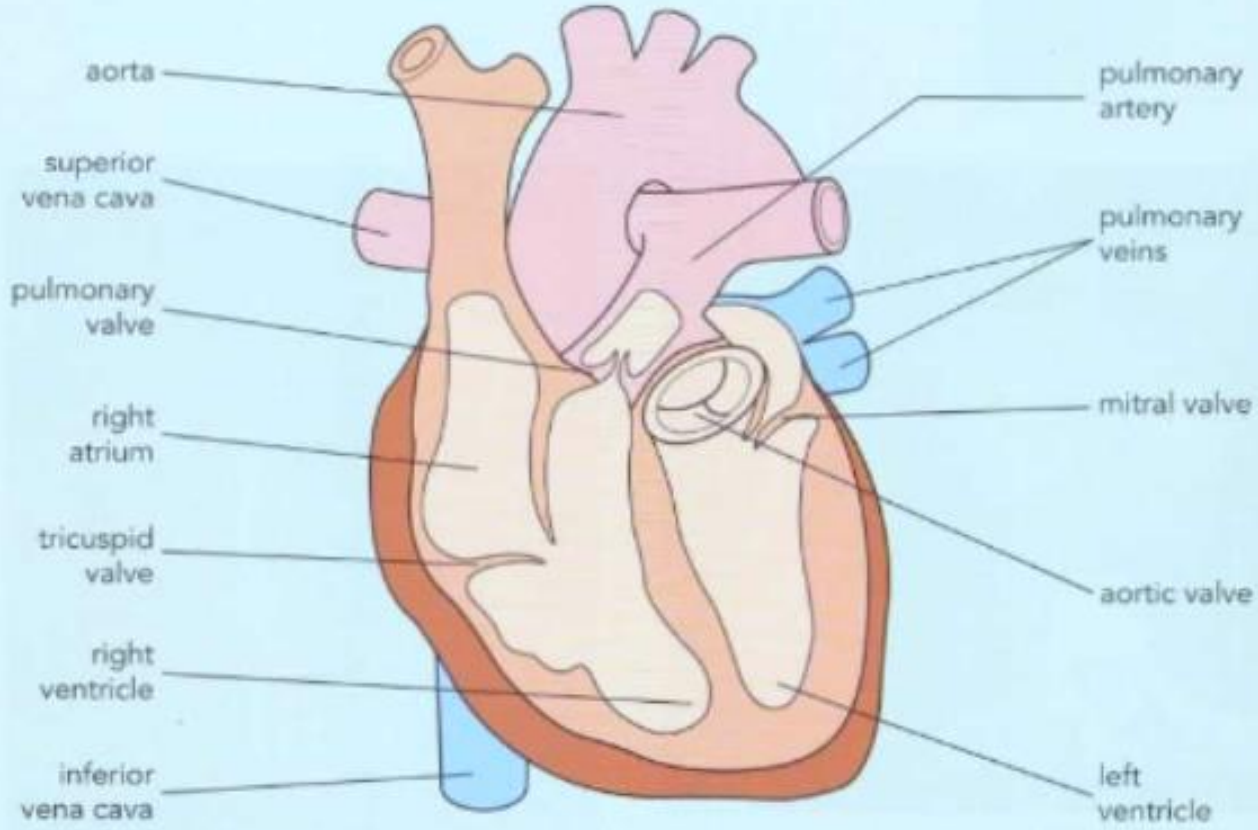
Système Veineux

- Système a basse pression
- assure le retour du sang vers le cœur = retour veineux
- Grande capacité : réservoir
- système de valvules



The chambers of the heart





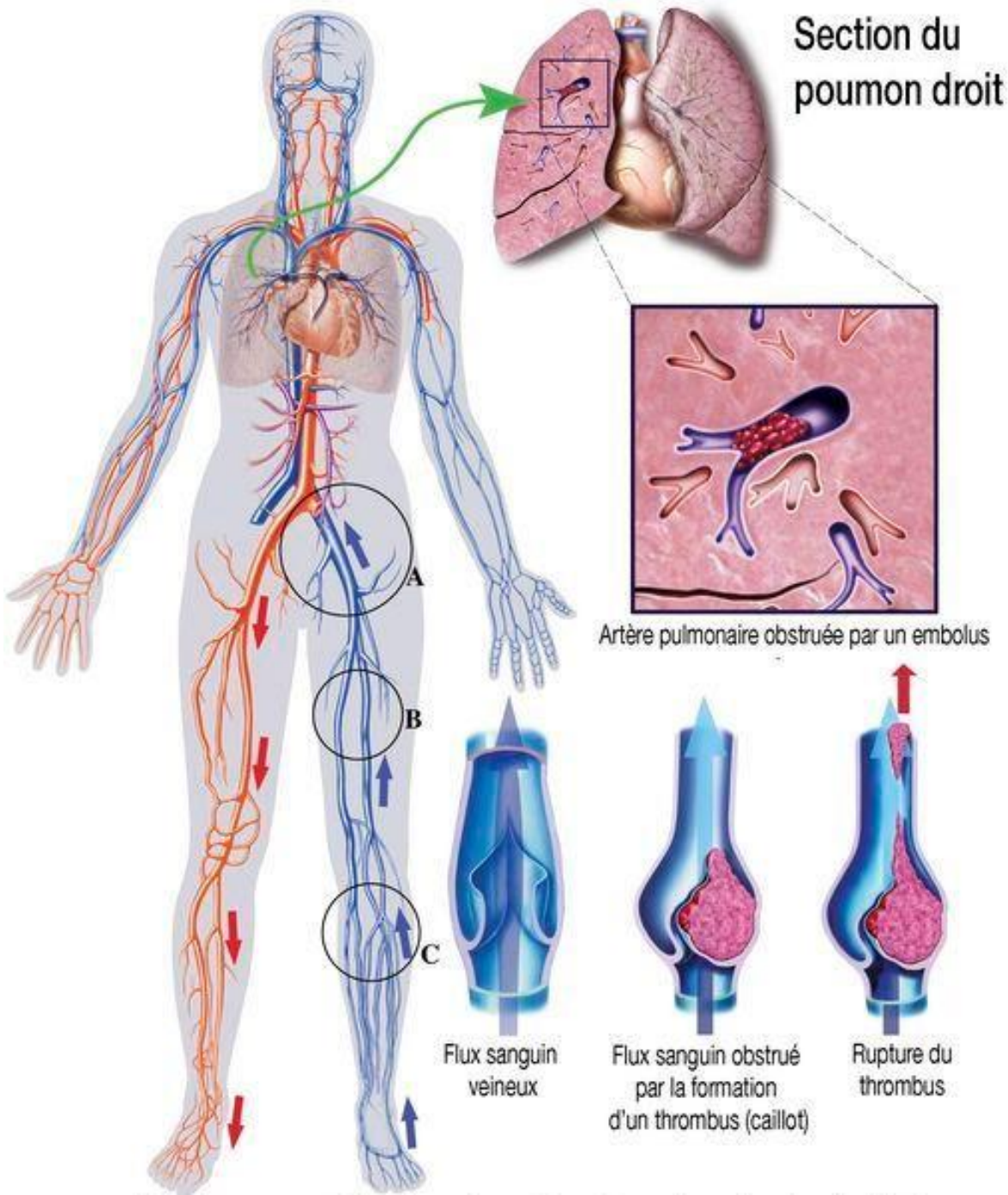
Maladie thrombo-embolique veineuse MTEV



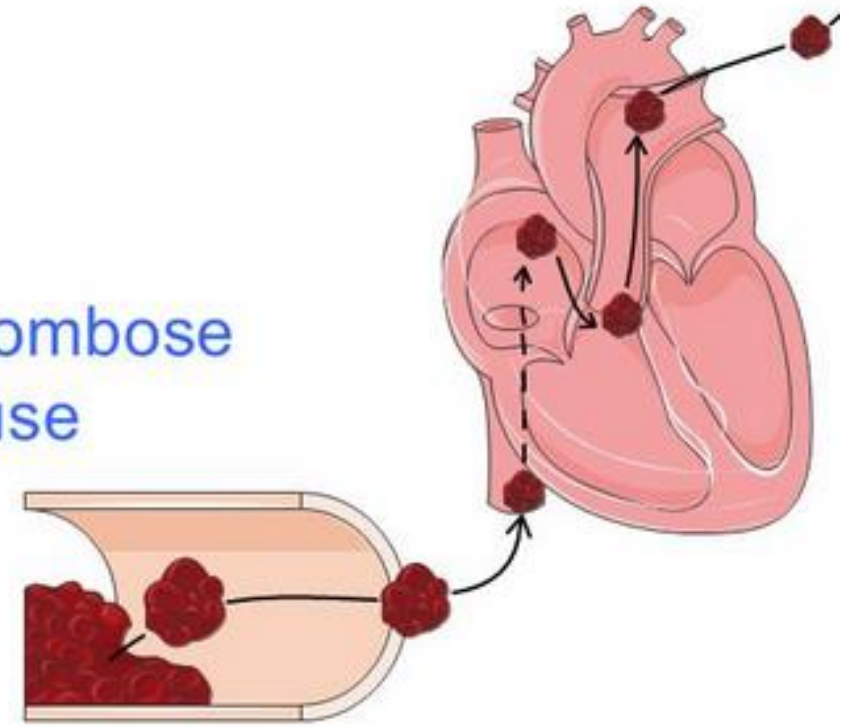
- **La Thrombose veinsue profonde TVP est indissociable de l'embolie pulmonaire EP sa complication directe**

- Concept de maladie thrombo-embolique veineuse MTEV

- Risque à court terme → EP
- Risque à long terme → Syndrome post phlébitique, Hypertension artérielle pulmonaire HTAP

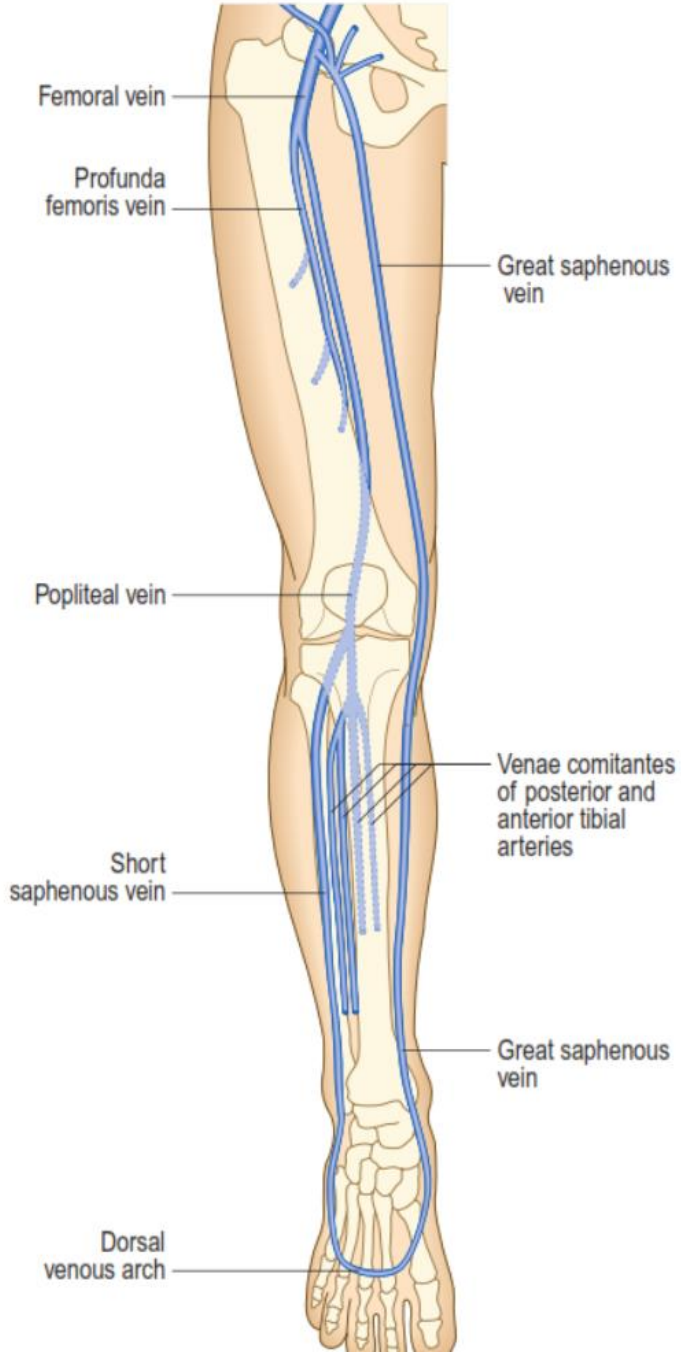


La thrombose veineuse



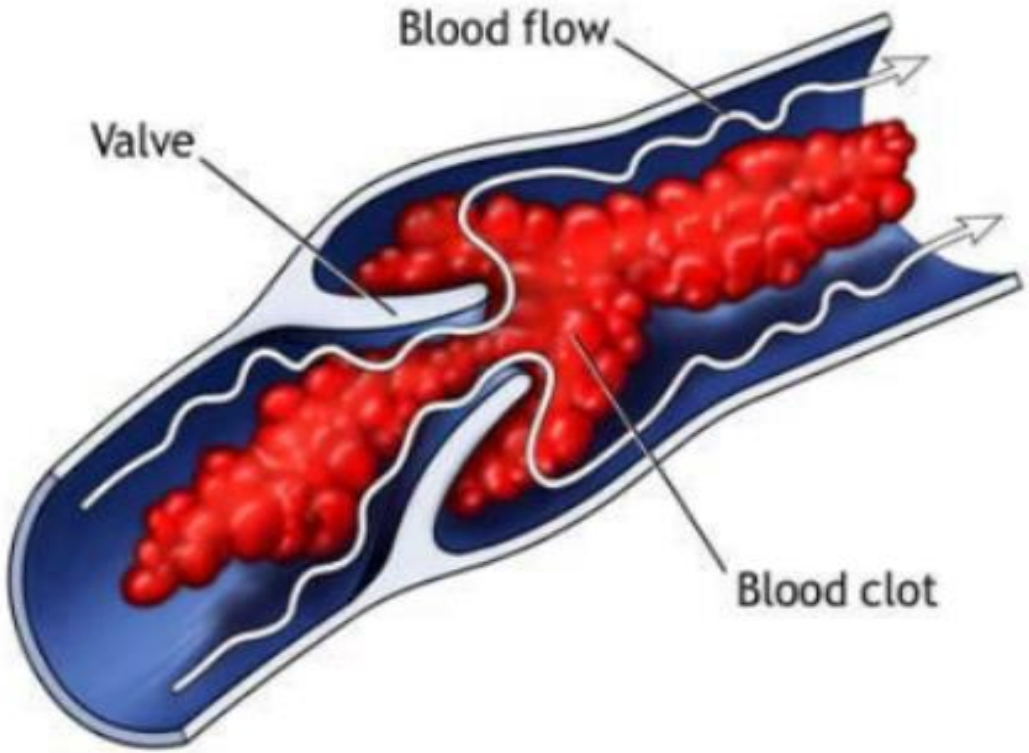
Thrombose veineuse profonde

veines des membres inférieurs



Thrombose veineuse profonde TVP (ex : phlébite)

- Obstruction d’une veine profonde par un thrombus



Triade de Virchow

- Stase veineuse
- Lésion pariétale
- Etat d’hypercoagulabilité



Facteurs de risque de TVP

- Intervention chirurgicale
- Alitement
- Immobilisation plâtrée
- Paralysie des membres
- Grossesse
- Prise d’oestro-progestatifs
- Insuffisance cardiaque
- Insuffisance respiratoire

- Cancer
- Thrombophilies héréditaires
- Syndrome des anticorps anti-phospholipides
- Syndrome néphrotique

TVP

Signes cliniques non spécifiques (varient selon le siège)

- Douleur ++
- Œdème de la jambe pouvant s'étendre à tout le membre (dépend du siège de la TVP)
- ↑ chaleur locale
- Dilatation des veines superficielles
- Perte du ballotement du mollet

Clinique TVP

- dorsi-flexion du pied entraîne une douleur au niveau du mollet

  → signe de Homans

pas très caratéristique = Peu spécifique

Parfois fièvre et tachycardie

Homan's sign



FIGURE 18.8 Assessment of the lower extremities. (**A**) The nurse checks for edema. (**B**) The nurse dorsiflexes the client's foot and asks if she feels any calf pain. No pain is a negative Homans' sign; pain is a positive Homans' sign that needs to be reported to the primary care provider immediately.

Non spécifique

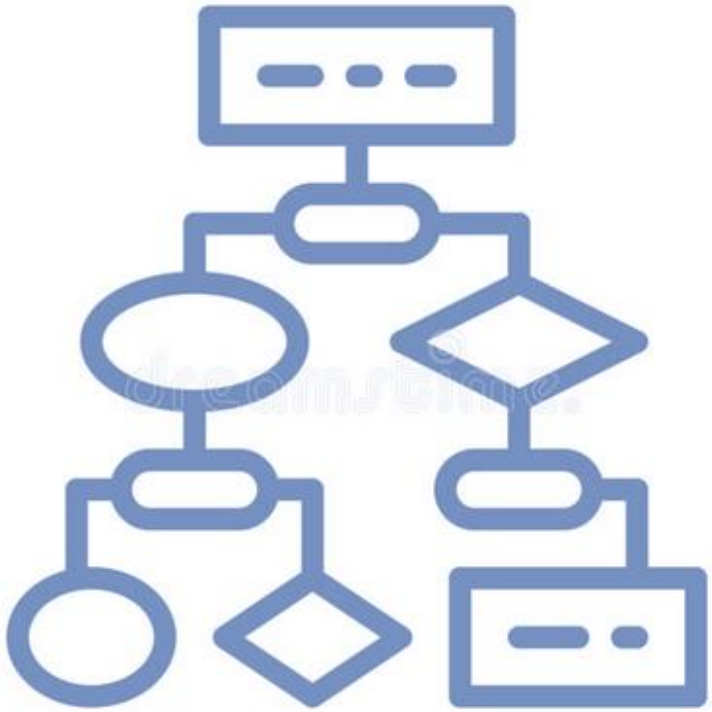




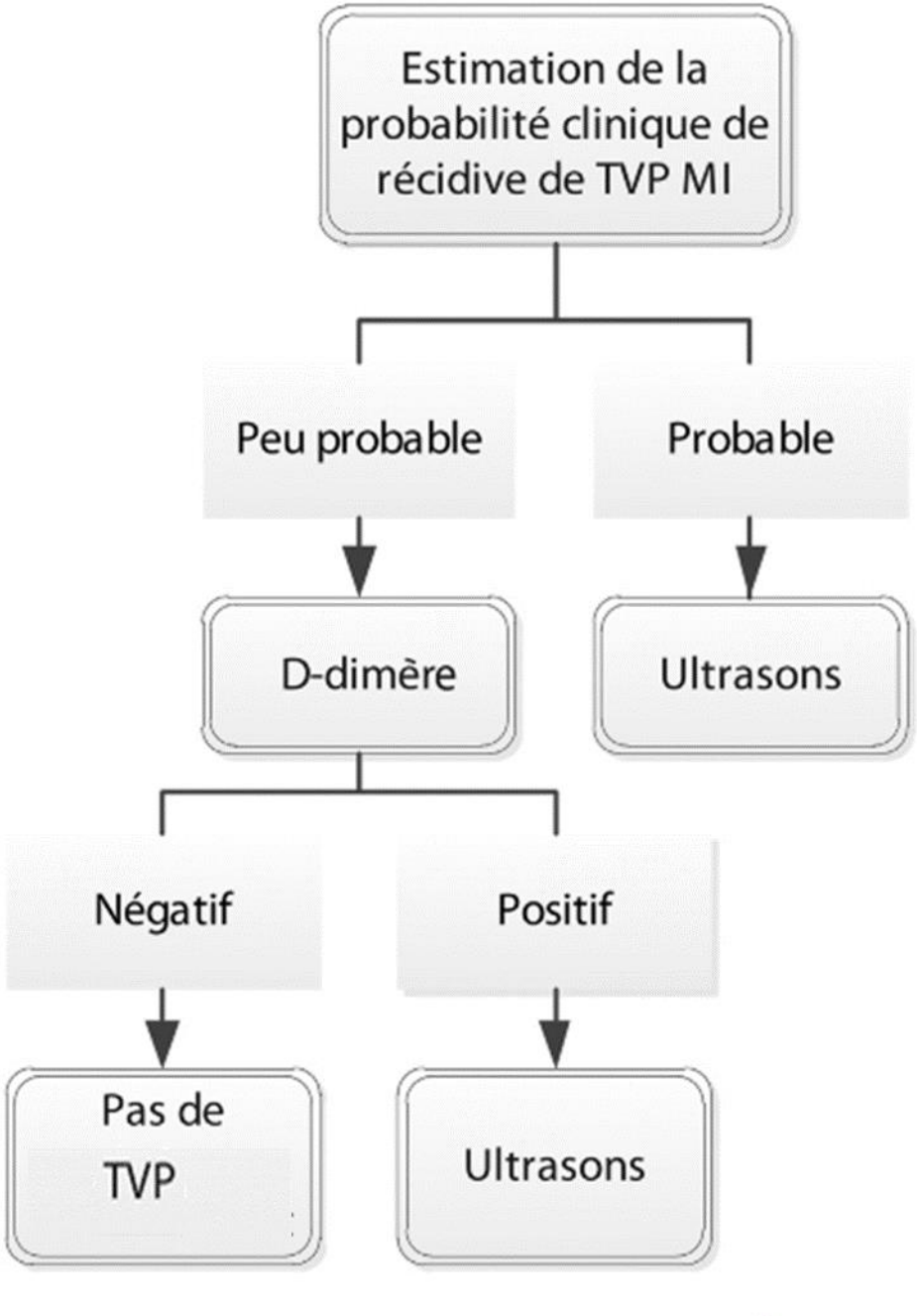


TVP : diagnostic

- Signes cliniques non spécifiques
- Formes parfois peu symptomatiques
- Importance du contexte +++ (facteurs de risques)
- Scores de probabilité clinique afin de faciliter le diagnostic
- Stratégie d'examens complémentaires bien codifiée!



Score de Wells modifié : TVP	
Item	**Points**
▮ Antécédents personnels de TVP	+ 1
▮ Cancer actif	+ 1
▮ Alitement ⩾ 3 jours ou chirurgie majeure < 12 semaines nécessitant anesthésie générale ou régionale	+ 1
▮ Paralysie/parésie/immobilisation plâtrée récente d'un membre inférieur	+ 1
▮ Augmentation de volume de tout un membre inférieur	+ 1
▮ Augmentation de volume du mollet > 3 cm par rapport au côté asymptomatique	+ 1
▮ Œdème prenant le godet du côté du membre inférieur symptomatique	+ 1
▮ Douleur sur le trajet d'une veine profonde	+ 1
▮ Collatéralité veineuse superficielle non variqueuse	+ 1
▮ Diagnostic différentiel au moins aussi probable que la TVP	- 2
TVP improbable	**< 2**
TVP probable	**⩾ 2**



Ultrasons =
Echo-doppler veineux

Société française de médecine vasculaire, 2019

Quel-est l'intérêt des D- Dimères ?

- Produits de dégradation de fibrine (thrombus)
- Dosage plasmatique
- Non spécifique
- Seuil à adapter selon l'âge (âge x 10) apartir de 50 ans
- Valeur prédictive négative si < 500 µg/L (faible probabilité) Permet d'éliminer de le Diagnostic

Elévation des D-dimères

- Age
- Grossesse
- Cancer
- Maladies inflammatoires

Dosage si : probabilité faible
Probabilité forte ou intermédiaire : Imagerie , D-dimères non nécessaires

Diagnostic : écho doppler veineux



Echodoppler Veineux : Examen de choix ++++

- Echographie de compression
- Examen non invasif
- Examen avec une bonne spécificité
- Permet le diagnostic
- Evalue l'étendu et l'extension proximale

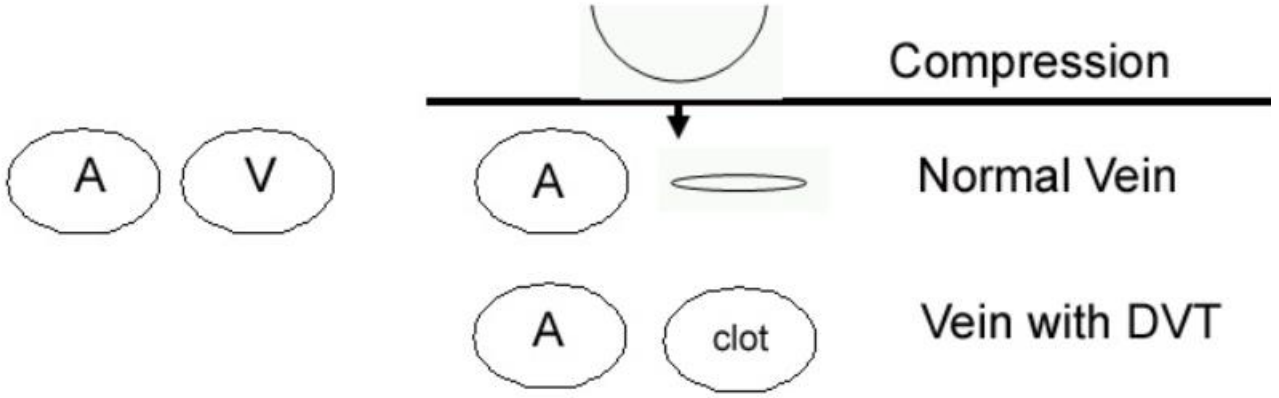


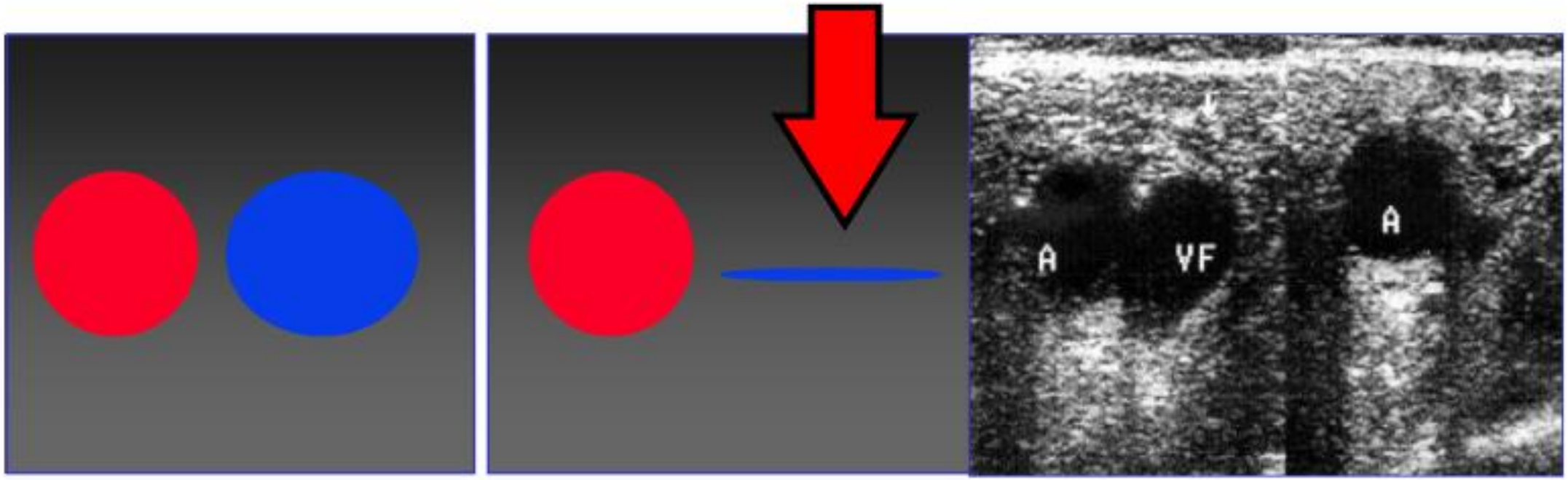


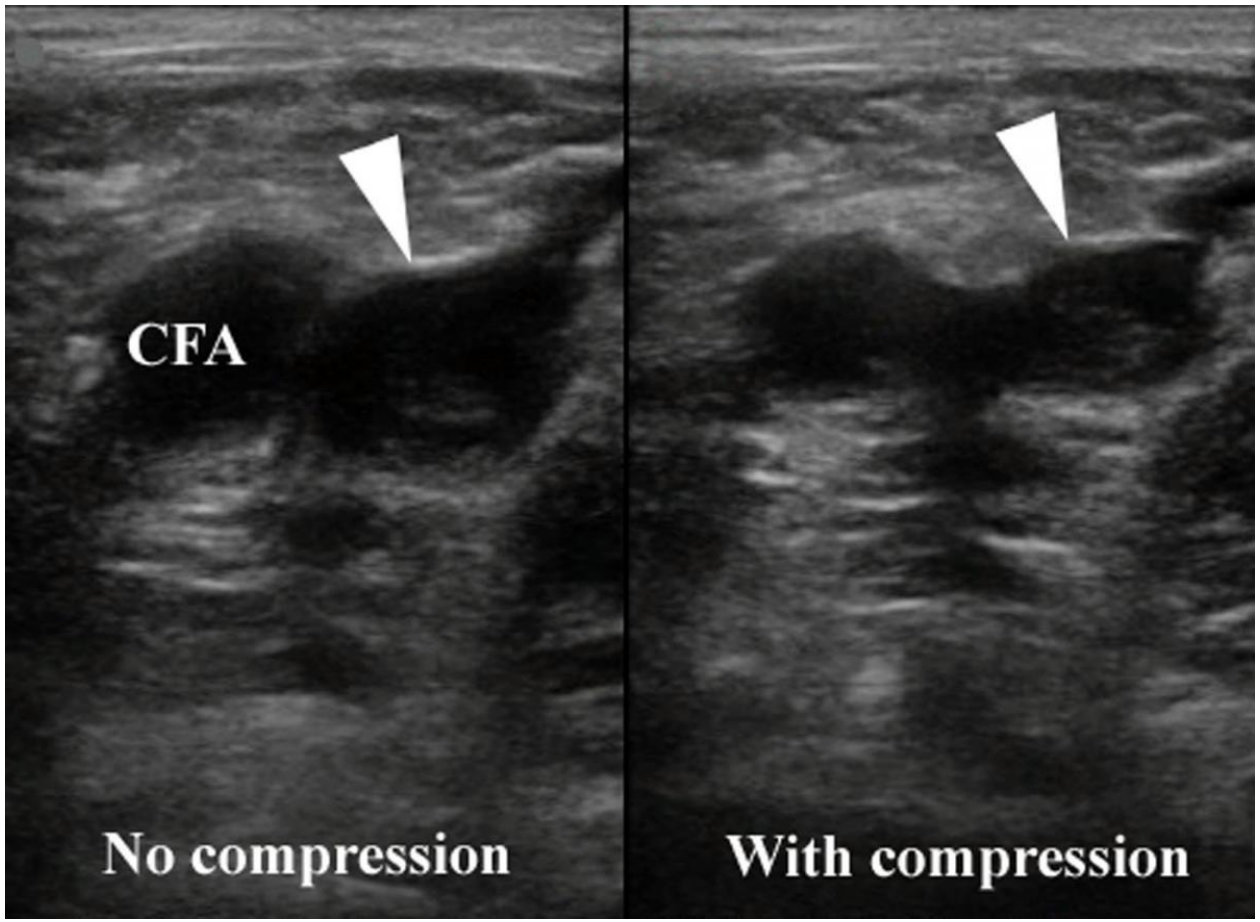

Diagnostic TVP


Diagnostic TVP

Echographie de compression






CFA
No compression
With compression

TVP : Plegmatia alba dolens

Forme clinique de TVP

TVP proximale (iliaque)

Œdème important +++

Tout le membre



Phlégmatia coerulia dolens

- Forme clinique grave de TVP
- compression des artères par l’œdème
- Ischémie artérielle



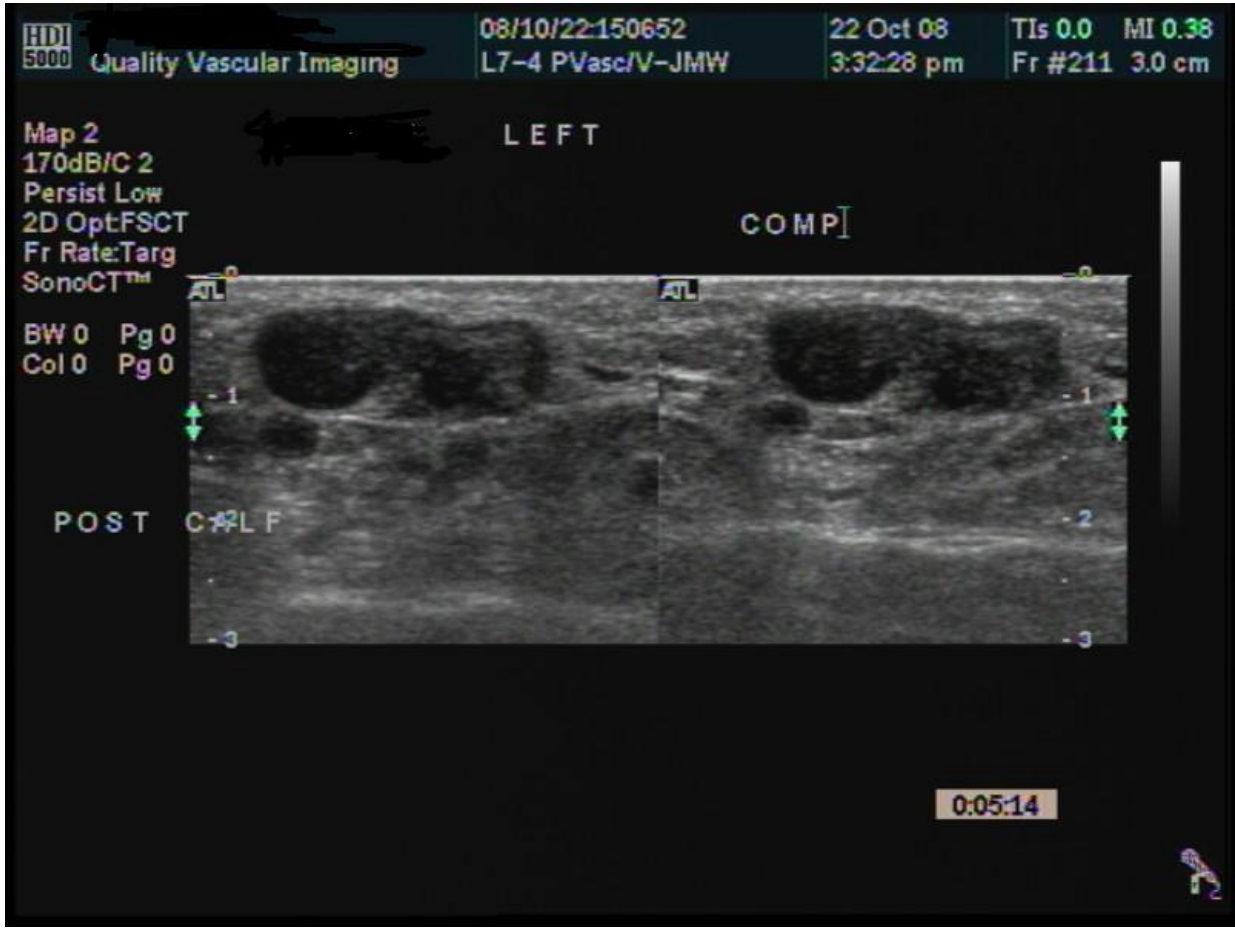
Thrombose veineuse superficielle

- Thrombose des veines superficiels
- Localisés en sous-cutané
- Signes cutanés :
  rougeur, placard inflammatoire
  sur le trajet de la veine
- Douleur



Thrombose veineuse superficielle





Diagnostic par écho-doppler des veines superficielles

Embolie pulmonaire

- La thrombose veineuse profonde est indissociable de l’embolie pulmonaire

La maladie thrombo-embolique

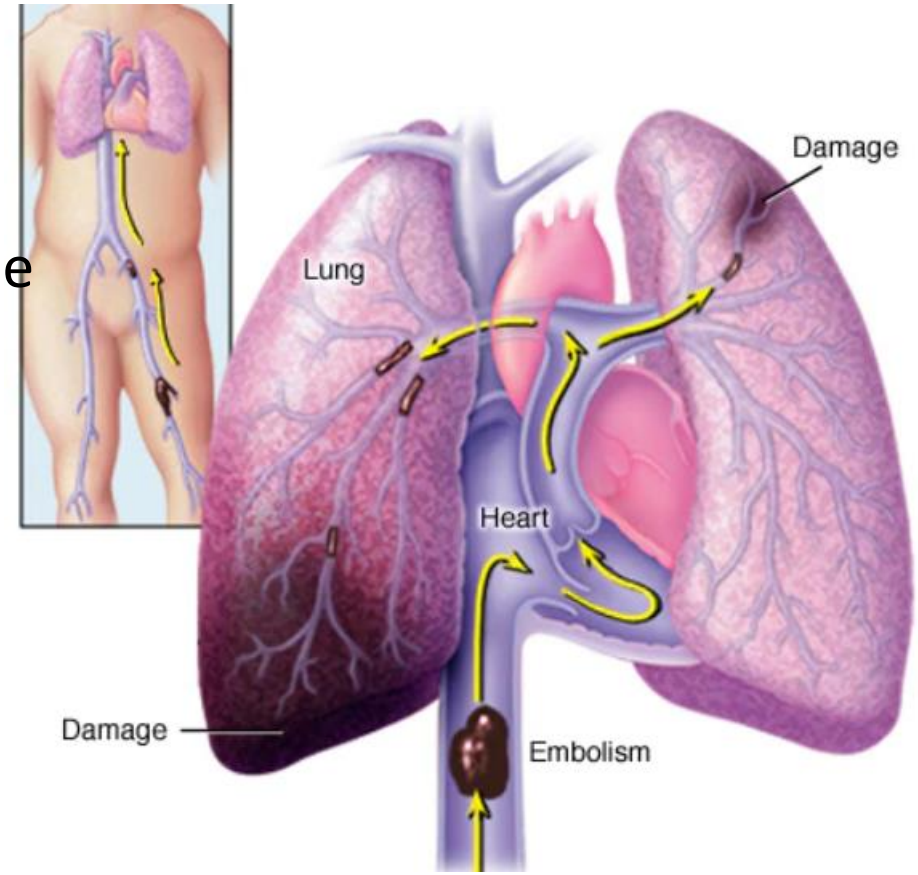
MTEV

Embolie pulmonaire

- L'embolie pulmonaire (EP) correspond à l'obstruction d'une ou plusieurs branches de l'artère pulmonaire par un thrombus.

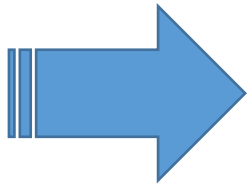
- Ce thrombus a généralement migré à partir d'une thrombose veineuse profonde (TVP) des membres inférieurs

- le diagnostic de l'EP est difficile en raison du caractère polymorphe de la présentation clinique.



Quand suspecter une EP ?

- Présentation polymorphe
- Signes manquant de spécificité
- Intérêt du contexte +++
- FDR de MTEV +++



Probabilité clinique

Signes fonctionnels

- absence de sensibilité et spécificité des symptômes cliniques.
- Caractère transitoire parfois
- Signes de thrombose veineuse uniquement dans 30% des cas
    - **Intérêt du contexte ++++**
    - **Facteur de risque de MTEV**

Principales manifestations cliniques :

- Dyspnée
- Douleur basithoracique ou latéro-thoracique
- Hémoptysie, expectoration hémoptoique
- Tachycardie
- Lipothymie
- Syncope

- Hypotension
- Défaillance ventriculaire droite
- Arrêt cardio-respiratoire
- Signes de thrombose veineuse profonde*

Signes fonctionnels

Tableau 1 : Principaux symptômes de l'EP

Symptômes	Fréquence
Dyspnée	70%
Douleur « pleurale »	66%
Toux	37%
Œdème de jambe	28%
Douleur de jambe	26%
Hémoptysie	13%

L'hémoptysie traduit un infarctus pulmonaire

Société française de médecine vasculaire

Signes physiques

Tableau 2 : Principaux signes physiques d'EP

Signes d'examen	Fréquence
Tachypnée (≥ 20/mn)	70%
Râles parenchymateux	51%
Tachycardie (> 100/mn)	30%
Eclat de B2	23%
Signes de TVP associée	11%

Société française de médecine vasculaire

Dyspnée

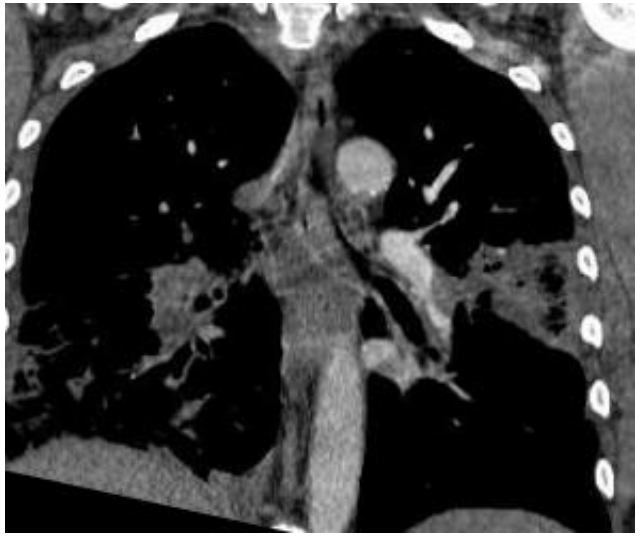
- L’EP doit être évoquée devant toute dyspnée aigue
- Liée à l’hypoxémie
- Parfois tachypnée
- liée à l’anxiété et à l’irritation pleurale parfois

Douleur thoracique :

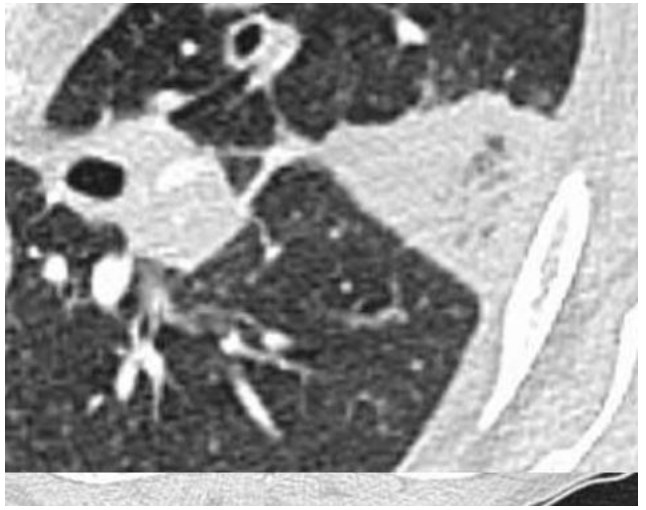
- Peut être absente ++
- Pas d’innervation sensitive dans la parenchyme pulmonaire
- de type pleurale
- Basithoracique ou latéro-thoracique
- Augmentée par les mouvements respiratoire et l’inspiration profonde
- liée à l'irritation de la plèvre au contact du parenchyme pulmonaire malade

Témoin parfois de la sévérité de l’EP par un mécanisme ischémique lié au bas débit cardiaque (ischémie VD)

L’infarctus pulmonaire



- Liée à l’obstruction d’une branche distale d’une artère pulmonaire
- Territoire systématisé
- Infarctus du parenchyme pulmonaire vascularisé par cette artère



- Douleurs thoracique
- Hémoptysie
- L’imagerie pulmonaire (radiographie, TDM) montre une opacité triangulaire à base pleurale

Examen clinique :

- peut être normal
- Fébricule parfois (38 c)
- Anxiété
- Tachycardie +++
- Polypnée
- Auscultation pulmonaire normale avec dyspnée → évocatrice d'EP ++
- Rythme irrégulier parfois (trouble du rythme supraventriculaire Fibrillation auriculaire)

L'examen clinique peut être strictement normal

Examen clinique :



Signes de gravité :

- Eclat de B2 pulmonaire
- Signe du galop

- Signes d'insuffisance cardiaque droite :
  - turgescence des jugulaires
  - hépatalgies
  - Reflux hépato jugulaire

- Signes de détresse respiratoire aigue :
  - Tachypnée > 30 cycles/min
  - tirage
  - cyanose

Examen clinique :



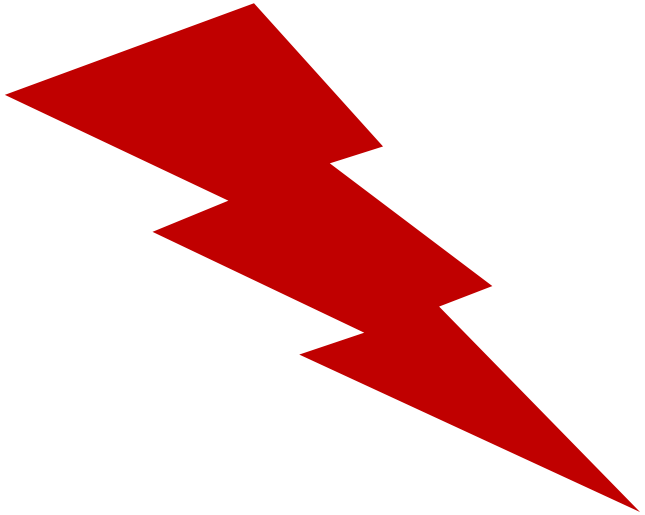
Signes de gravité : ebmolie pulmonaire grave

Signes de choc :

- Hypotension artérielle PAS < 90 mmHg
- Oligurie
- Marbrures
- Extrémités froides
- Agitation
- Confusion

Il existe des formes graves d’EP :

- hypotension
- Choc cardiogénique
- Insuffisance cardiaque droite aigue
- Syncope
- décès



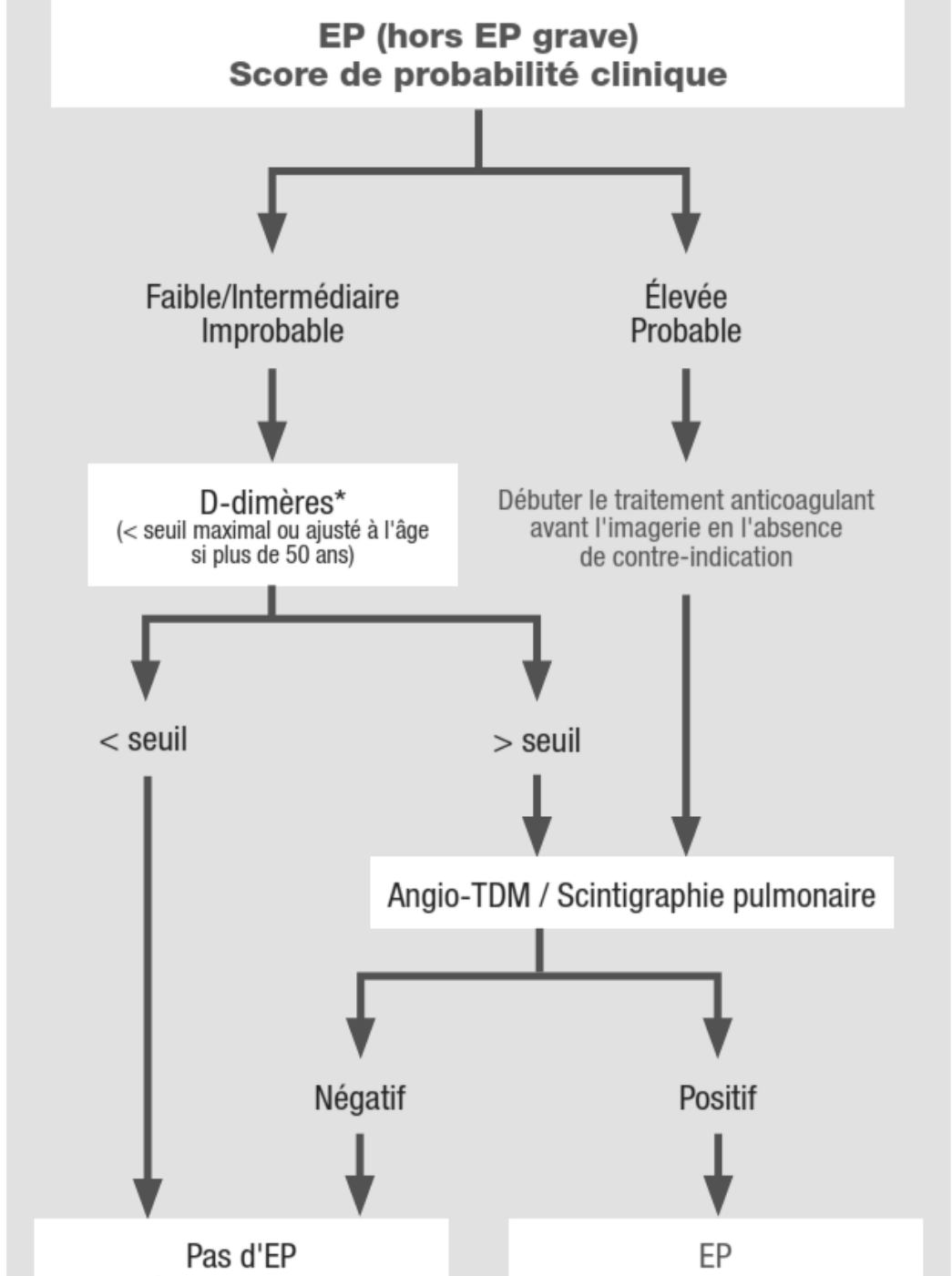


Embolie pulmonaire : Score de Wells simplifié

Item	Score
Antécédent de TVP/EP	+1
Chirurgie ou immobilisation récentes	+1
Cancer actif	+1
Fréquence cardiaque ≥ 100/min	+1
Signes cliniques de TVP	+1
Diagnostic alternatif moins probable que EP	+1
Hémoptysie	+1
Score total Score ≤ 1 : EP improbable (score faible) Score > 1 : EP probable (score fort)	

Il existe une version de ce score avec 3 niveaux de probabilité

Faible : < 2 points
Intermédiaire : 2 à 6 points
Forte : > 6 points


EP (hors EP grave)
Score de probabilité clinique
Faible/Intermédiaire
Improbable
Élevée
Probable
D-dimères*
(< seuil maximal ou ajusté à l'âge si plus de 50 ans)
Débuter le traitement anticoagulant avant l'imagerie en l'absence de contre-indication
< seuil
> seuil
Angio-TDM / Scintigraphie pulmonaire
Négatif
Positif
Pas d'EP
EP

Examens complémentaires EP

Diagnostic positif :

- **Angioscanner (TDM) pulmonaire +++ (en premier)**
- Scintigraphie pulmonaire de perfusion (parfois)
- Echodoppler veineux membres inférieurs (si non disponibilité, contre indication angioscanner)
- Angiographie : exceptionnelle

Examens complémentaires EP

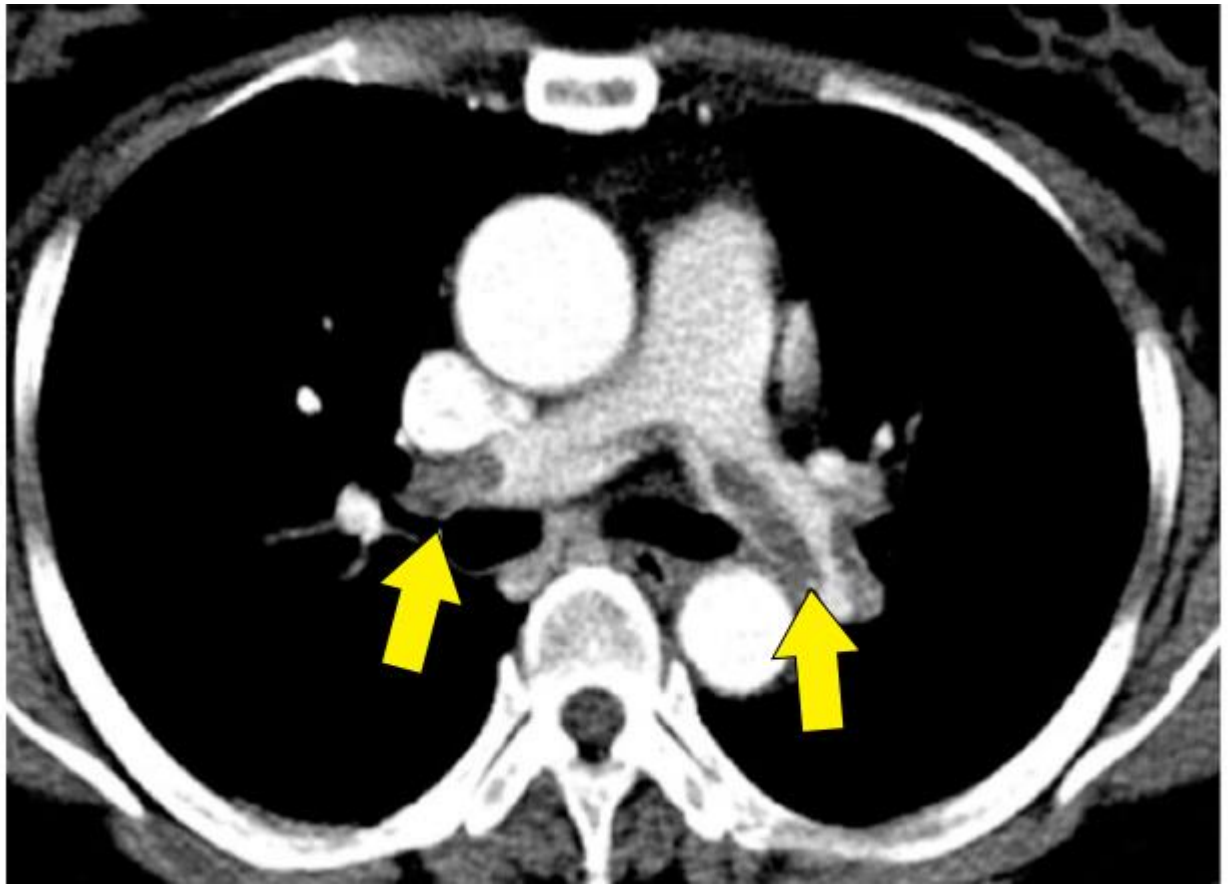
Pour Apprécier la gravité :

- Echographie cardiaque +++ (dilatation des cavités droites)
- ECG
- Gaz du sang
- Troponines

Autres examens :

- Radiographie pulmonaire
- Bilan biologique : bilan rénal, hémostase, glycémie, FNS, groupage

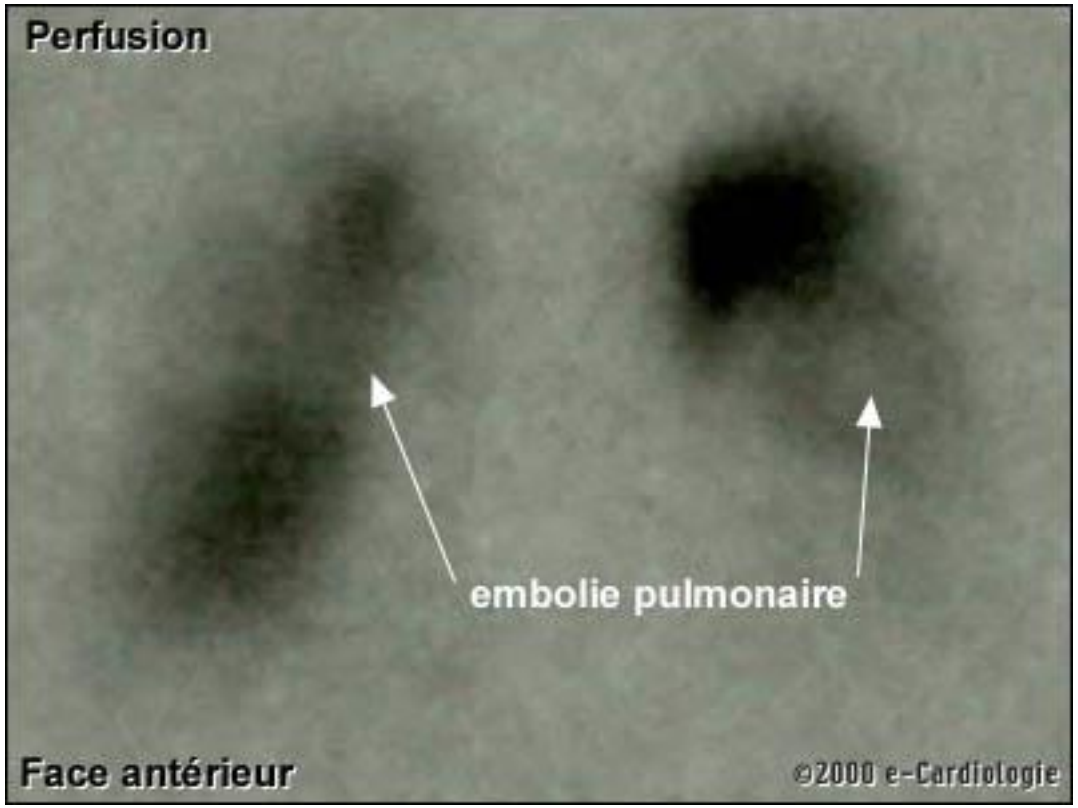
Embolie pulmonaire : angio-scanner



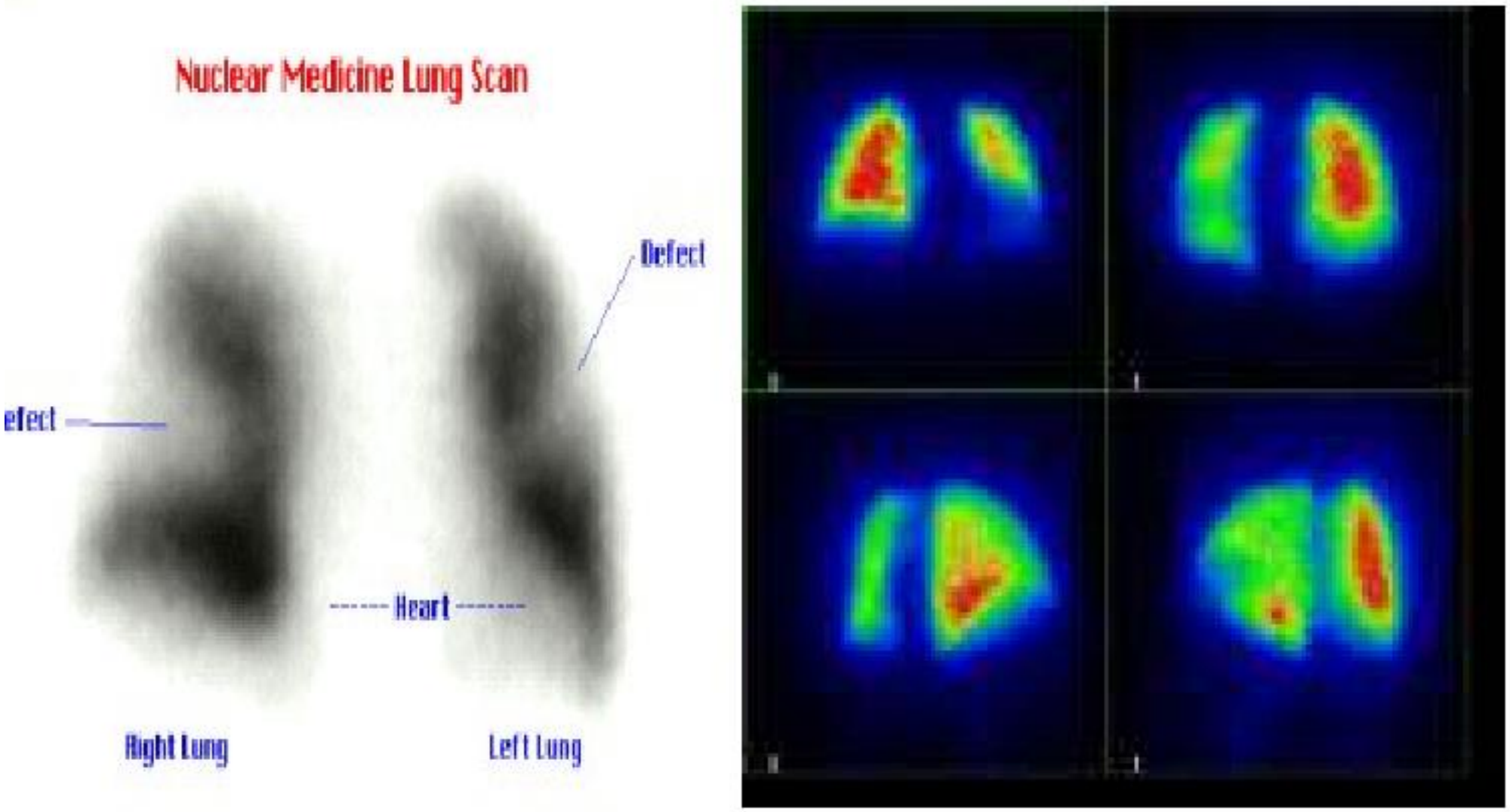
Embolie pulmonaire : angio-scanner

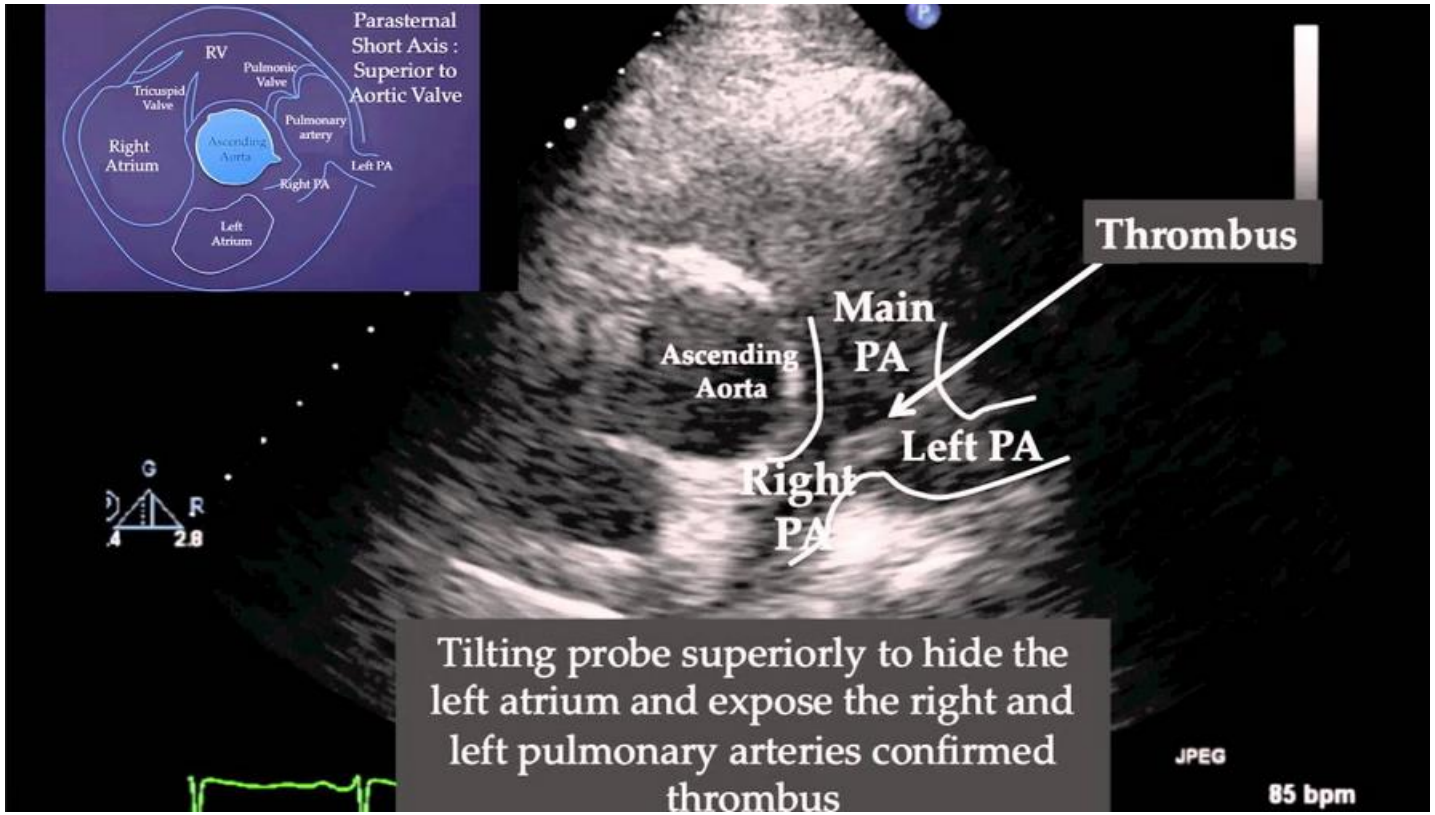


Embolie pulmonaire : scintigraphie pulmonaire



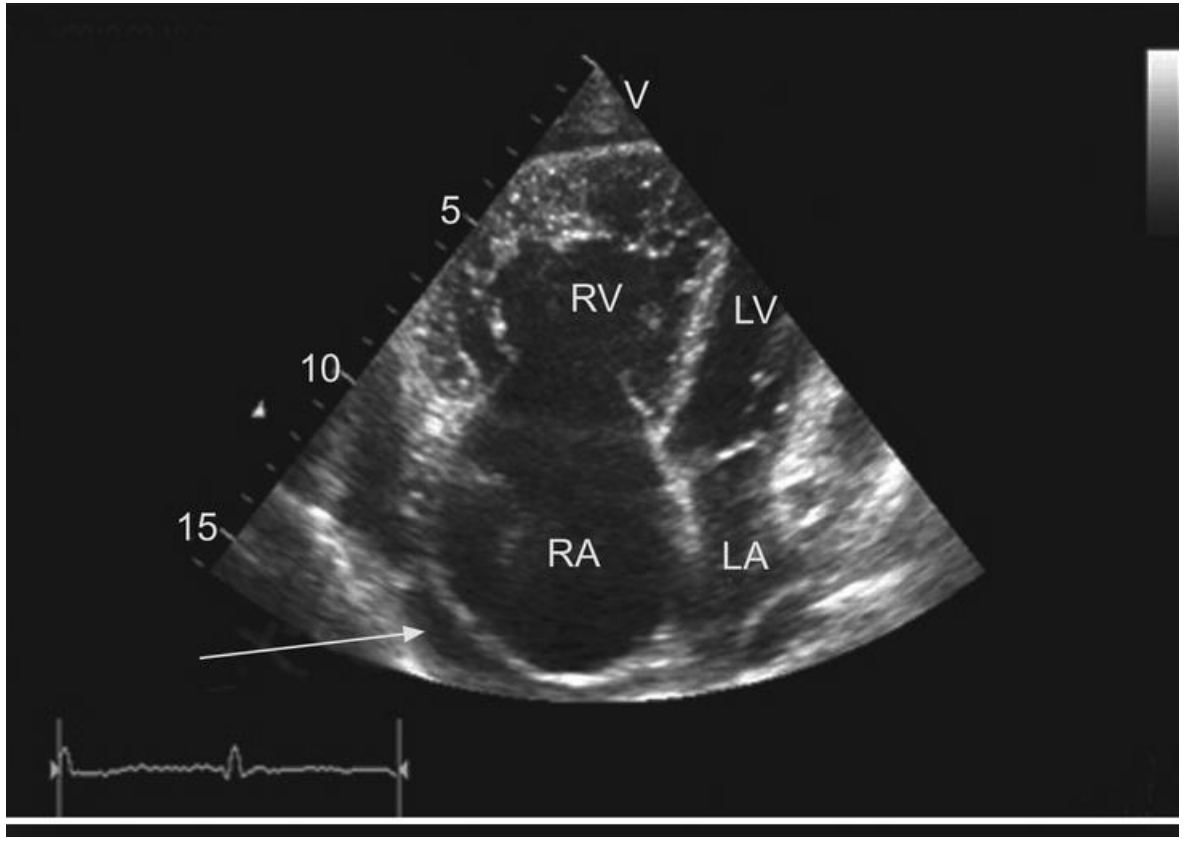
Scintigraphie pulmonaire

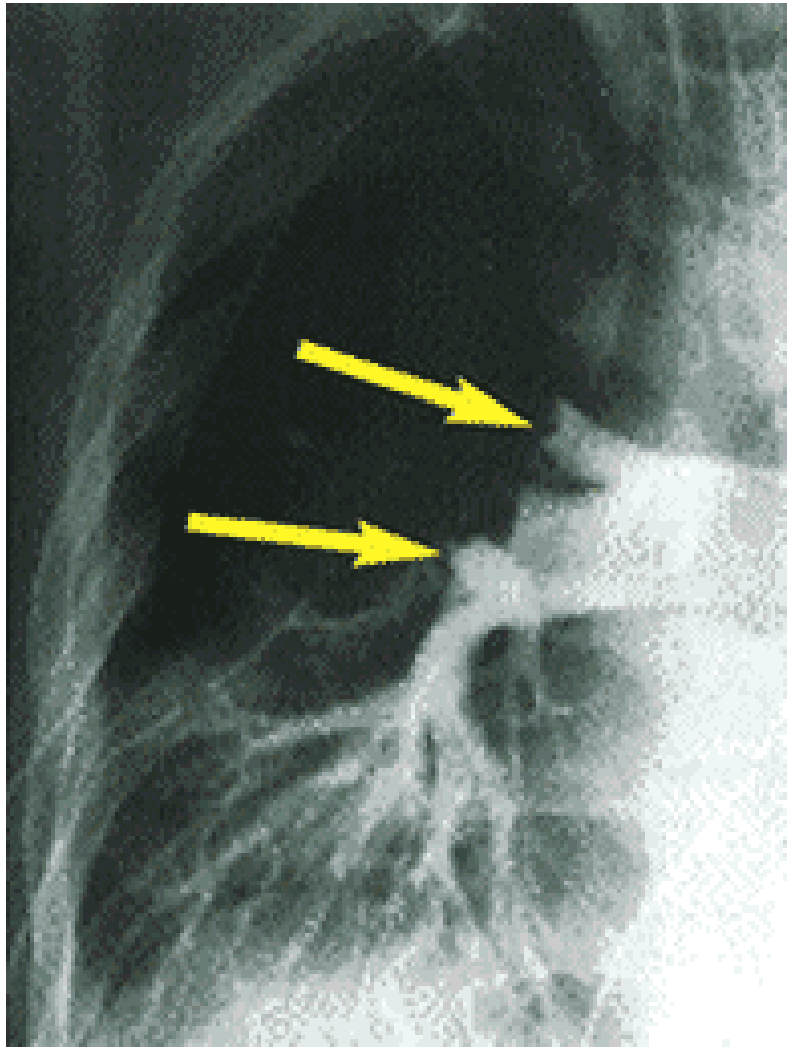



Parasternal
Short Axis :
Superior to
Aortic Valve
RV
Pulmonic
Valve
Tricuspid
Valve
Pulmonary
artery
Right
Atrium
Ascending
Aorta
Left PA
Right PA
Left
Atrium
Thrombus
Main
PA
Ascending
Aorta
Left PA
Right
PA
Tilting probe superiorly to hide the left atrium and expose the right and left pulmonary arteries confirmed thrombus
JPEG
85 bpm


B N JHA,53/M
RIDGE HEART CENTRE
ID:b n jha
*New Cardiac
3S
11:13:17 am
28-Jul-10
2D 26 cm
48 f/s
f: 1.6 MHz H
DR: 60 dB
R: 2.0 G: 77
P:0dB
TIs:0.8
MI:1.0
HR: 112 BPM


04/2013 15:06:02
V
5
10
15


V
5
10
15
RV
LV
RA
LA



Angiographie pulmonaire avec obstruction totale des artères segmentaires pulmonaires supérieures et moyennes

Insuffisance veineuse chronique

Insuffisance veineuse IVC

- Ensemble de manifestations clinques en rapport avec l'altération du retour veineux
- Système veineux superficiel des membres inférieurs +++
- Affection fréquente
- La varices constituent une manifestation de l'IVC
- Le syndrome post-thrombotique constitue une manifestation de l'IVC

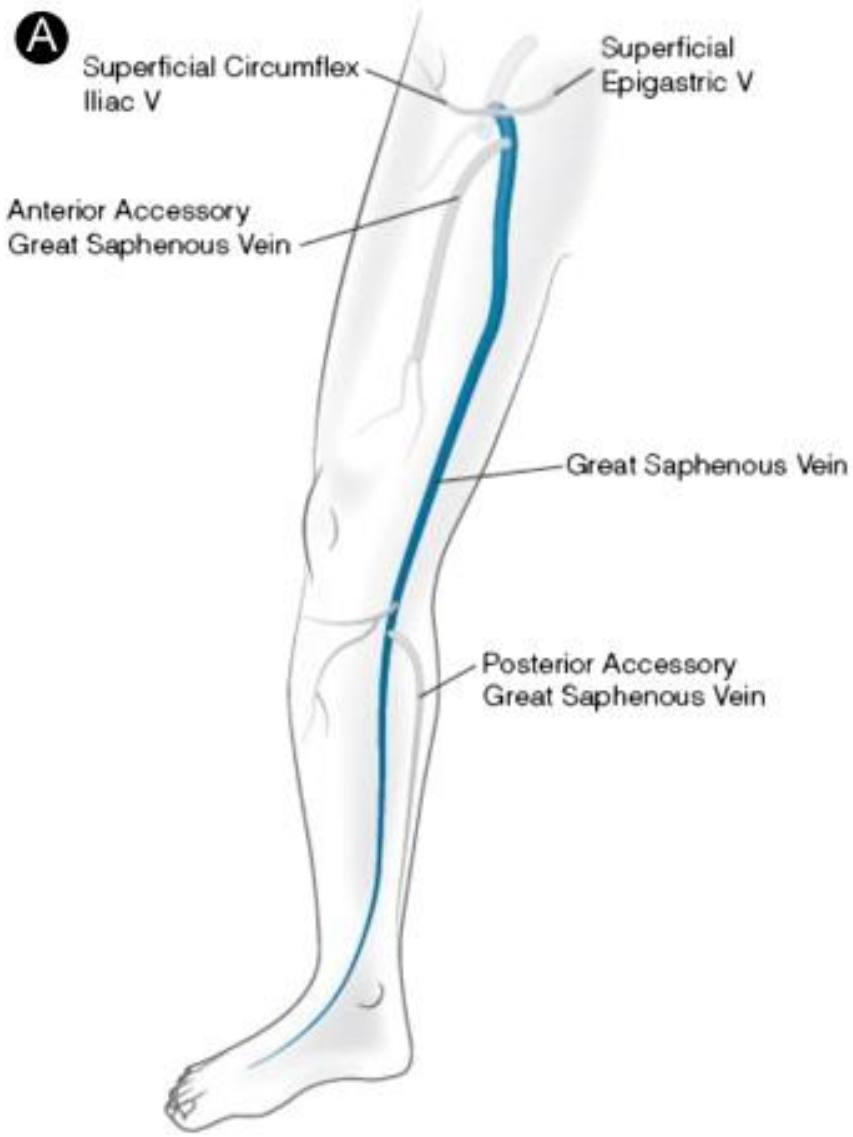
Insuffisance veineuse : signes cliniques

- Lourdeur de jambes, sensation de pesanteur
- Douleurs parfois invalidantes
- Crampes nocturnes
- œdèmes de la cheville
- Dilatation des veines du pied

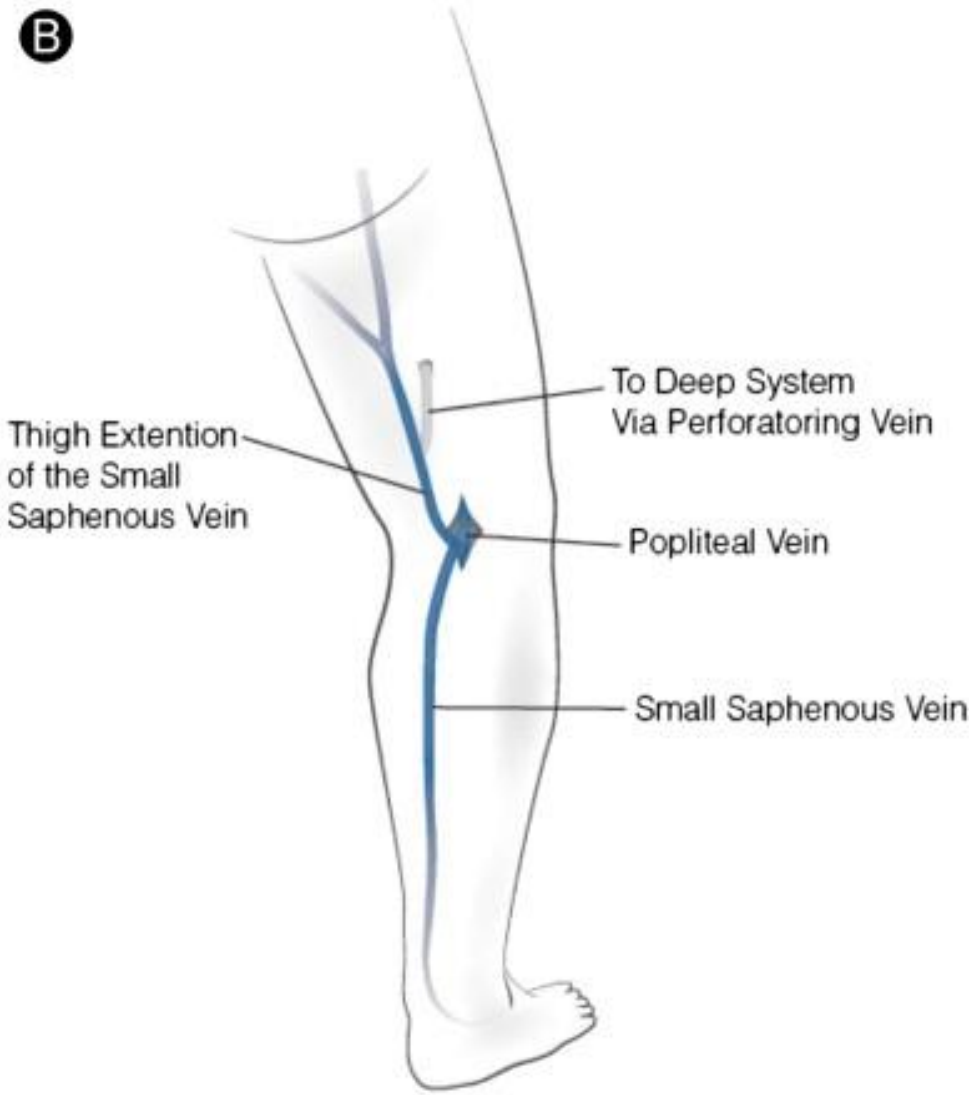
Insuffisance veineuse : signes cliniques (stade évolué)

- Dermite ocre (hyperpigmentation)
- Epaississement cutané
- Prurit
- Ulcère de jambe

Système veineux superficiel



Grande veine saphène



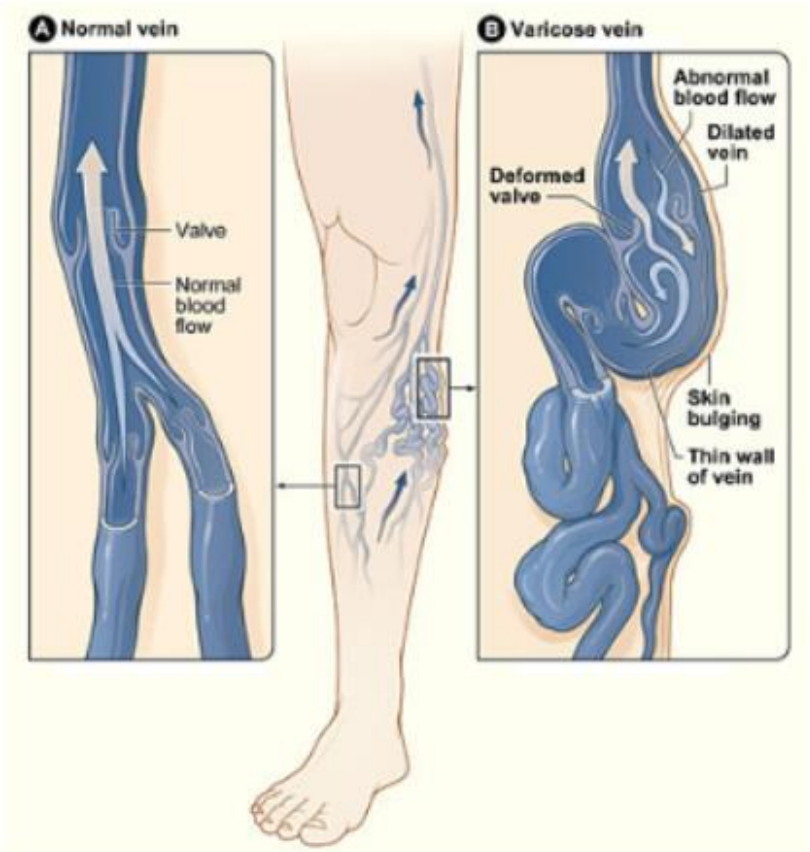
Petite veine saphène

Varices membres inferieurs

- dilatations localisées des **veines superficielles**
- Accentuées en position debout
- Sinueuses
- Reflux par insuffisance valvulaire (les veines saphènes +++)

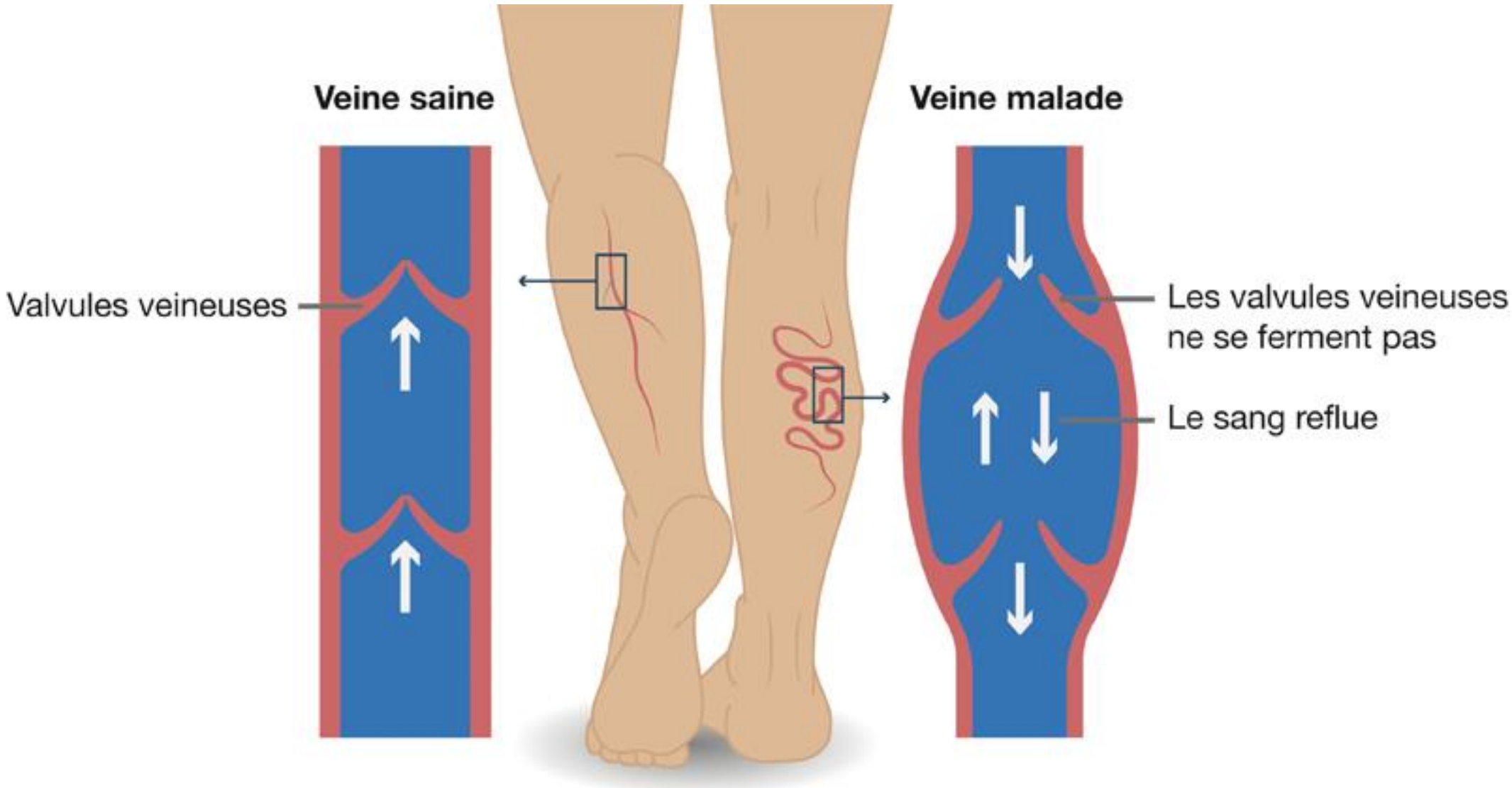
témoignent d’une Insuffisance veineuse +++

Varices



- Définition

« une varice est une veine sous-cutanée des membres inférieurs dilatée, tortueuse et de longueur augmentée »


Veine saine
Veine malade
Valvules veineuses
Les valvules veineuses
ne se ferment pas
Le sang reflue

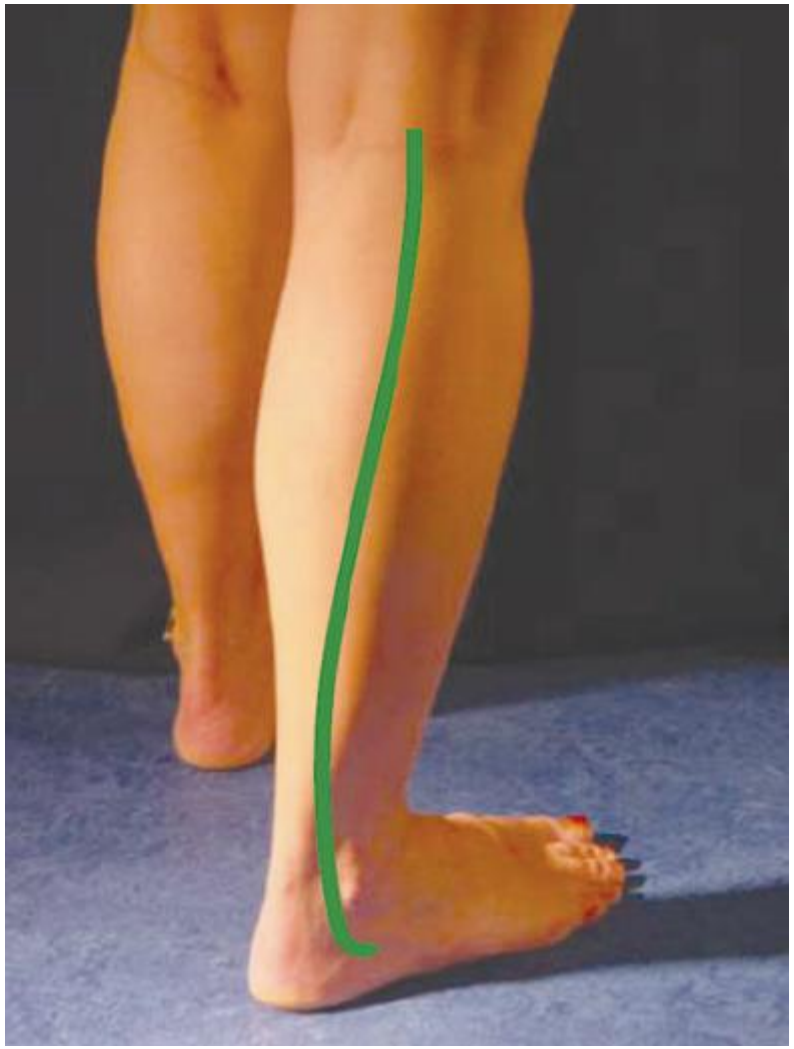
Examen clinique

- En position debout ++
- Examen des veines superficielles
- Palpation des veines superficielles si dilatées
- (grande et petite veines saphènes, varices)
- Rechercher les signes d’IVC





Grande veine saphène



Petite veine saphène

IVC : signes physiques



IVC : signes physiques



Telangiectasias



Reticulares



Tronculares

Varices


MaCirculation


(C) Site FMC Dermatologie




www.ulcere-de-jambe.com
Dr F.Vin



Syndrome post-thrombotique SPT

- Complication a long terme
- TVP +++



Syndrome post-thrombotique SPT

Signes fonctionnels :

- Douleurs MI
- Crampes
- Paresthésies
- prurit

Signes physiques (MI) :

- Hyperpigmentation
- Rougeur
- Induration
- Dilatation veineuse

- **Ulcère de jambe +++**



Figure 1. Postthrombotic syndrome.

Importance du diagnostic clinique

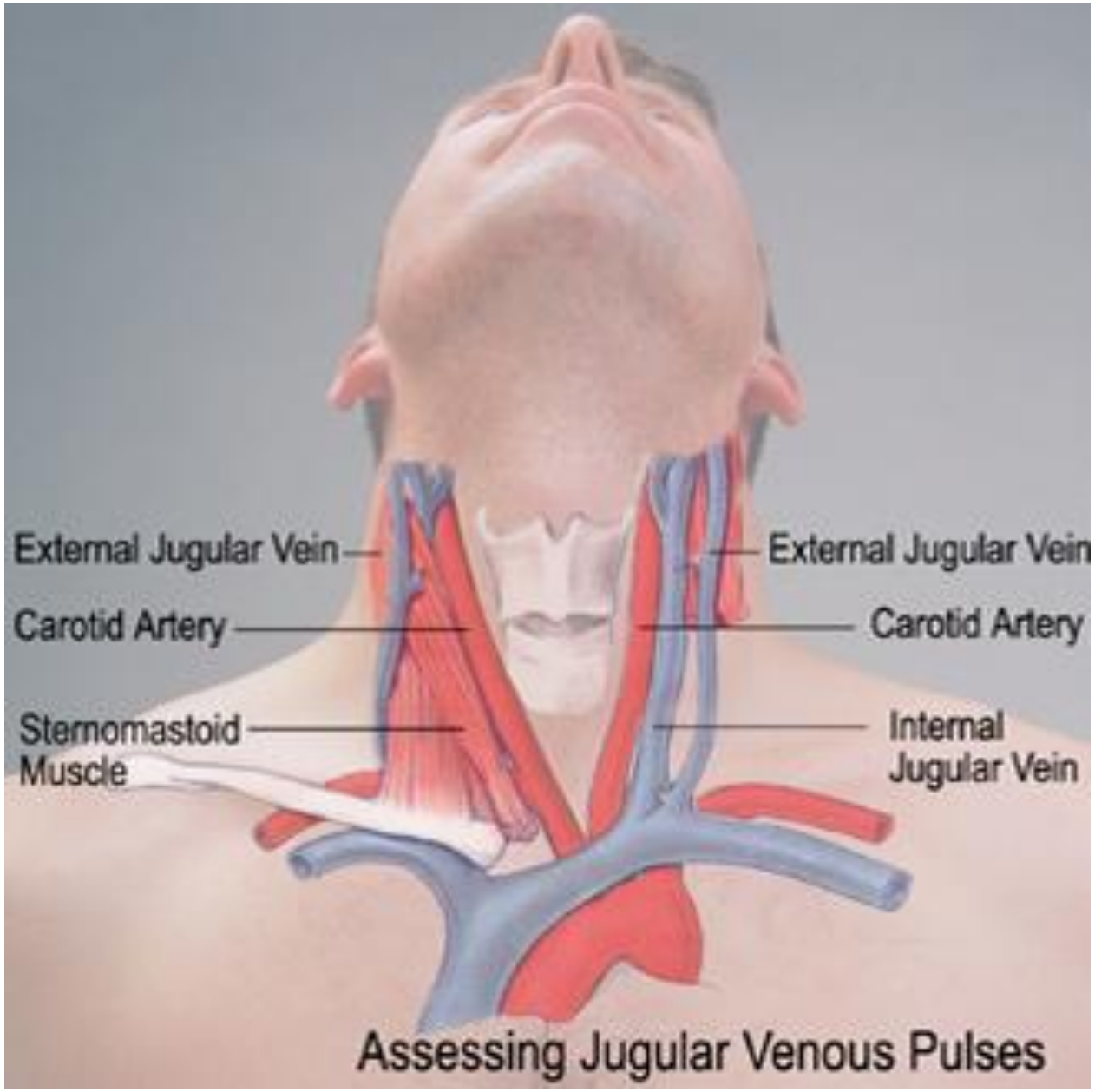
blood
2009 114: 4624-4631
Prepublished online September 9, 2009;
doi:10.1182/blood-2009-07-199174

How I treat postthrombotic syndrome

Susan R. Kahn


www.ulcere-de-jambe.com
Dr F.Vin

Examen des jugulaires

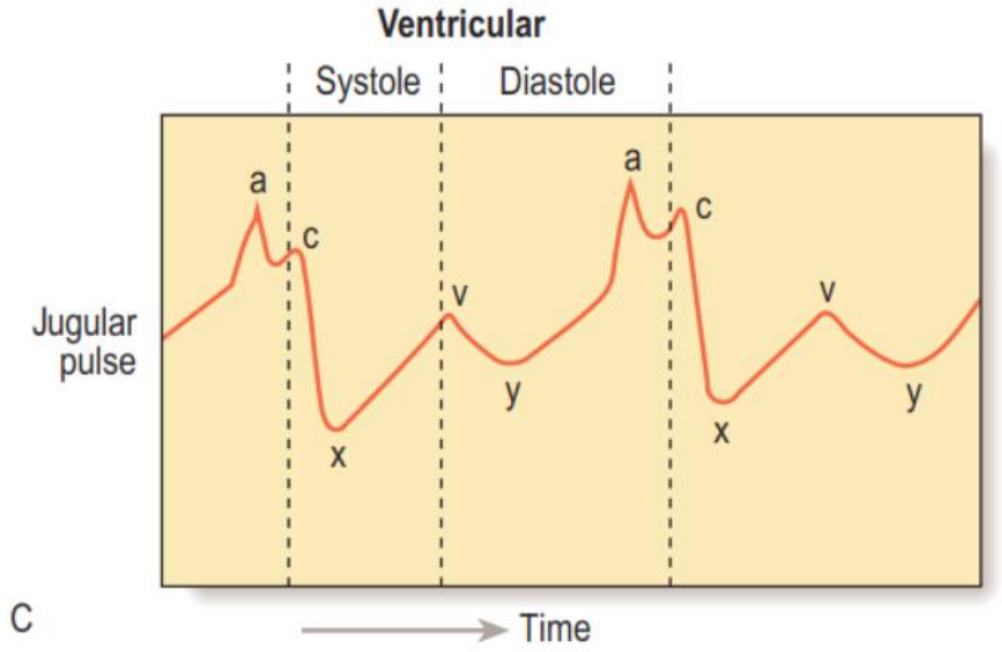

External Jugular Vein
Carotid Artery
Sternomastoid Muscle
External Jugular Vein
Carotid Artery
Internal Jugular Vein
Assessing Jugular Venous Pulses

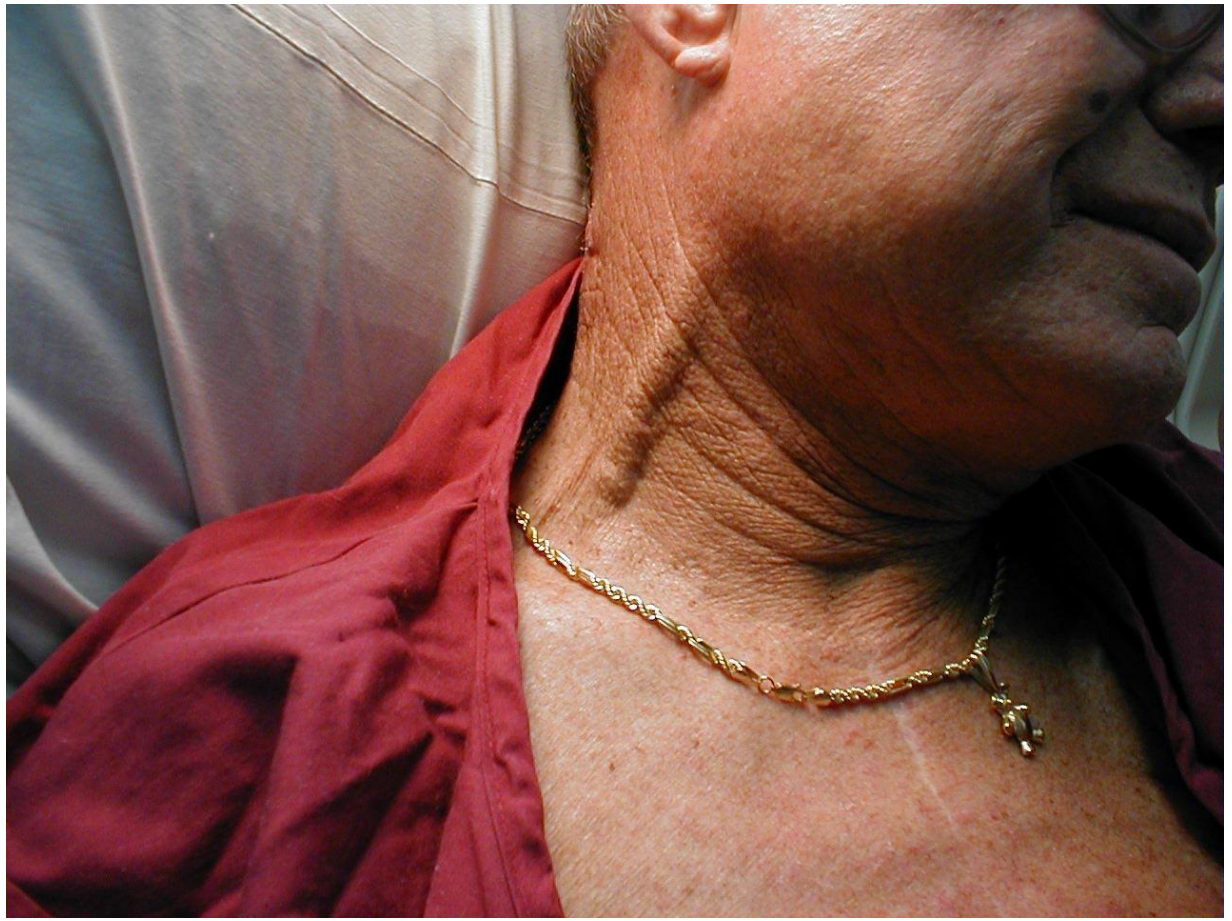
Examen des jugulaires

- Son aspect reflète les variations de pression de l'oreillette droite

La turgescence des jugulaires :

signe d’insuffisance cardiaque droite





Turgescence des jugulaires





reflux hépato-jugulaire

- la compression du foie → ↑pression veineuse dans la veine jugulaire droite → turgescence prolongée au moins une minute après la cessation de la compression

signe traduisant une insuffisance ventriculaire droite



Reflux hépato-jugulaire



Syndromes Caves

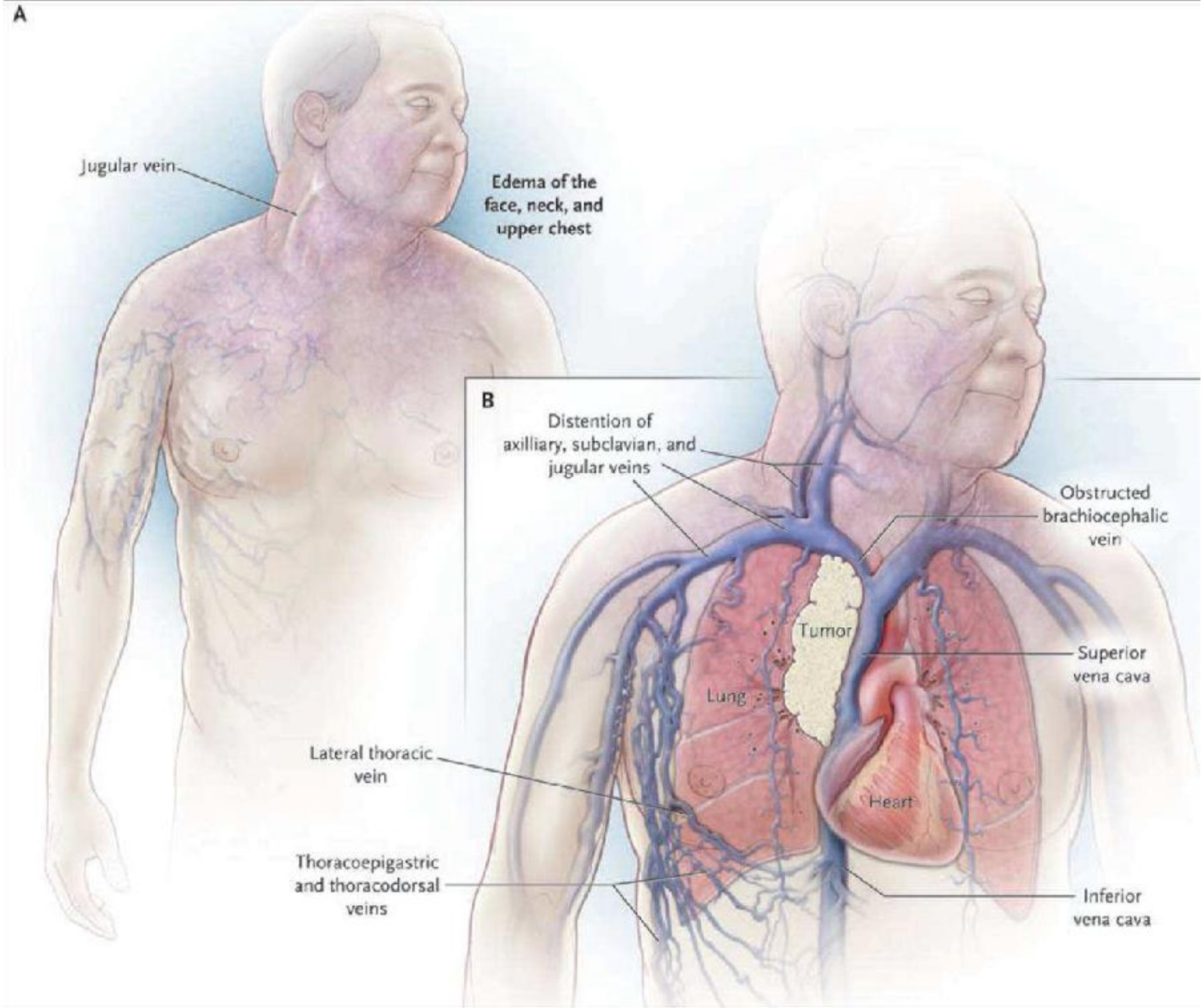


Syndrome cave supérieur

- œdème de du visage
- œdème en pèlerine
- circulation veineuse collatérale superficielle thoracique
- Turgescence jugulaires et les veines du visage
- Cyanose

Causes :

- Thrombose veine cave sup
- Compression par une tumeur médiatisnale ou pulmonaire


A
Jugular vein
Edema of the face, neck, and upper chest
B
Distention of axilliary, subclavian, and jugular veins
Obstructed brachiocephalic vein
Tumor
Superior vena cava
Lung
Lateral thoracic vein
Heart
Thoracoepigastric and thoracodorsal veins
Inferior vena cava


A
B


A
C

Obstruction de la veine cave inférieure : sémiologie

- Thrombose ou compression par une tumeur abdominale ou lombaire
- circulation veineuse collatérale abdominale
- œdèmes des membres inferieurs , bilatéraux, fermes
- Douleurs abdominales ou pelviennes parfois
- Nausées et vomissements parfois